# Sémiologie vasculaire Périphérique

Pr M.Benmamar

chirurgien vasculaire

Faculté de médecine d'Oran

# Sémiologie vasculaire

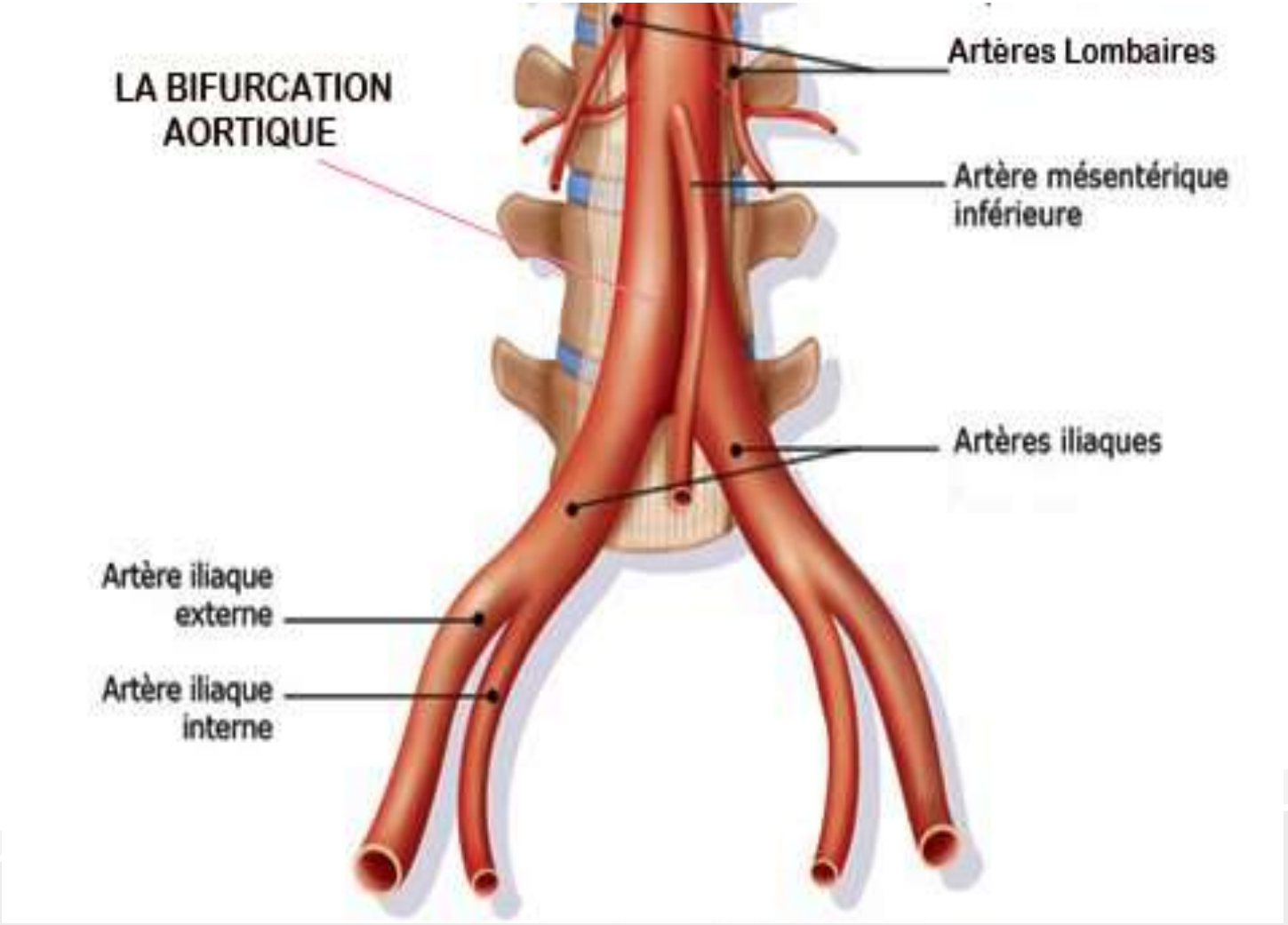
- Sémiologie artérielle.

Sémiologie veineuse.

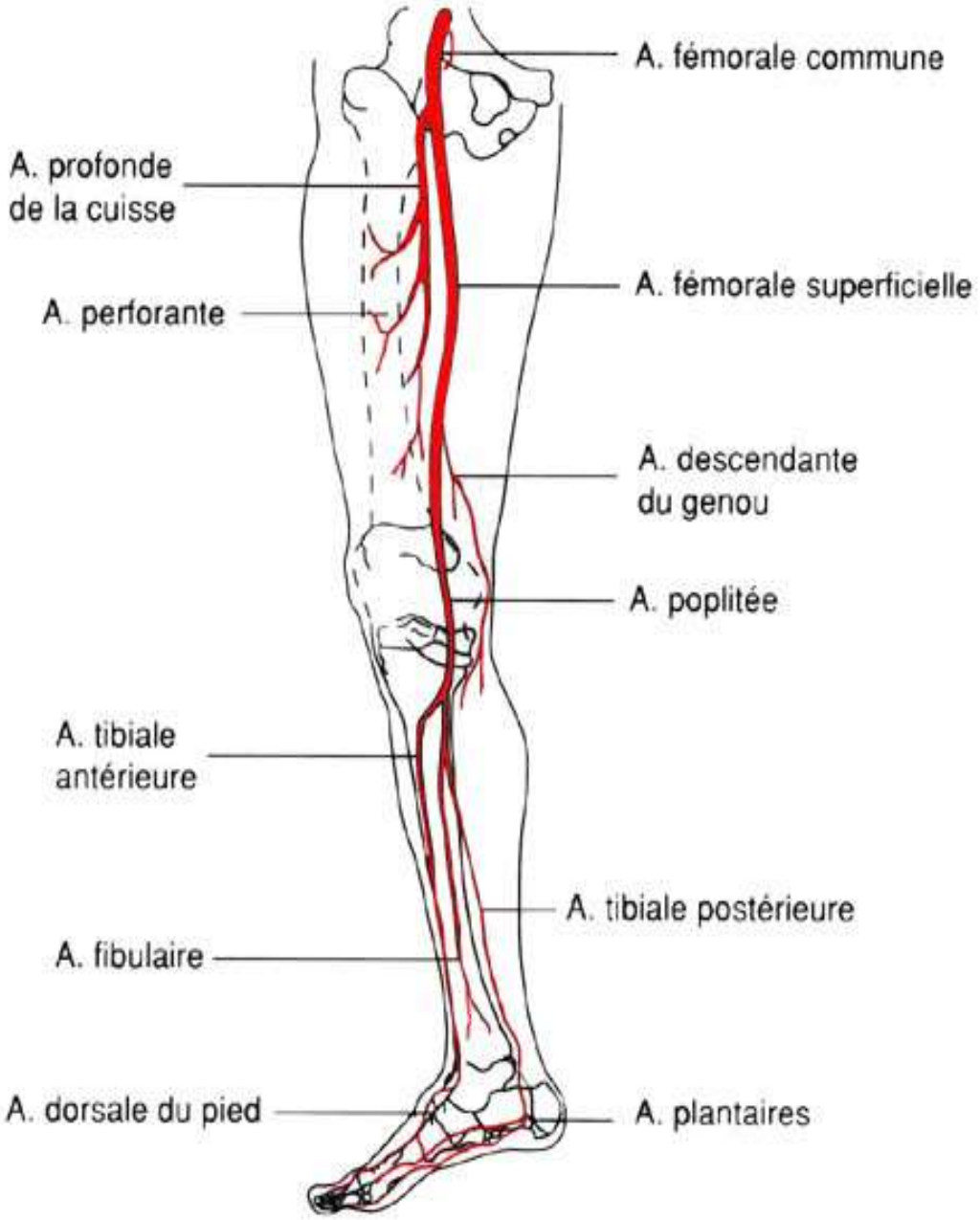
# Introduction:

- Les pathologies vasculaires sont de plus en plus fréquentes en Algérie.
- L'atteinte cardio-vasculaire représente l'une des première causes de mortalité dans notre pays.
- La connaissance de la sémiologie vasculaire est primordiale afin de pouvoir diagnostiquer ces pathologies en réalisant un examen clinique précis et rigoureux.

# Anatomie artérielle



# Anatomie artérielle



# Examen clinique

**Motif de consultation +++**

Douleur au membre.

Troubles trophiques cutanés: cyanose, pâleur, ulcération, nécrose, gangrène.

Froideur distale.

# Interrogatoire

- Il est capital , permet de préciser :
- Les antécédents personnels et familiaux du patient médicaux et chirurgicaux
- Préciser le type de douleur , son heure de début, son niveau et son irradiation.
- Les FDR Athéromateux.

# Interrogatoire
# FDR ATS

- Age
- Sexe
- Tabac passif et actif
- Diabète , HTA
- Sédentarité , Obésité
- Dyslipidémie
- Mode de vie, Activité physique et alimentation.

# Examen clinique

## Signes généraux :

- Etat général
- Etat de conscience
- Température ,fièvre (infection gangrène abcès)
- Aspect des conjonctives(anémie)
- Poids: amaigrissement

Douleurs abdominales post prandiales Art digestives ???

# Signes fonctionnels:

- **Douleur: Claudication intermittente :**

Se sont des douleurs siégeant au niveau de la fesse, de la cuisse, mollet, ou la voute plantaire. Cette douleur est déclenchée par l'effort physique à la marche cédant au repos définissant ainsi que le périmètre de marche.

**Douleur de repos (de décubitus):**

Douleur permanente au repos s'aggravant la nuit relativement calmées par la position assise jambes pendantes. Elle est l'expression d'une ischémie grave mal compensée et le signe précurseur de la nécrose.

# Claudications intermittentes



## ***Classifications de l'AOMI***

| **Clinique / hémodynamique** | | **Leriche et Fontaine** | | **Rutheford** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Stade* | *Clinique* | *Grade* | *Clinique* | *Grade* | *Catégorie* | *Clinique* |
| 1 | asymptomatique | I | asymptomatique | 0 | 0 | asymptomatique |
| 2 | ischémie d'effort | II A | claudication intermittente, >200m | I | 1 | claudication légère |
| | | | | | 2 | Claudication moyenne |
| | | II B | claudication intermittente, <200m | | 3 | Claudication sévère |
| 3 | ischémie de repos | III | douleur de décubitus | II | 4 | Douleur de repos |
| | | IV | troubles trophiques | III | 5 | Perte mineure de substance |
| | | | | IV | 6 | Perte majeure de substance |

# Récapitulant



# L’ischémie critique :

- Douleurs en position allongée permanentes avec ou sans troubles trophiques avec un index de pression systolique inférieur à 0.4 et une pression transcutanée en oxygène inférieure à 30mmHg.



# Examen physique
## Inspection

**ETAT CUTANE :**

- Membre atrophié, Atrophie musculaire.
- Etat des phanères : ongles cassants, secs.
- Retard de cicatrisation d'une plaie.
- Etat de la pilosité des membres.
- Couleur du membre : peau cyanosée, pale.
- Nécrose, un ulcère de jambe ou gangrène.
- Erythrocyanose de déclivité.



# ONGLES CASSANTS



Hyperkératose des ongles

Sècheresse cutanée



Escarre du talon

Début de nécrose



Nécrose sèche des orteils et de l'avant pied



Ulcère de jambe avec Mise à nu d'un tendon infecté



# Embolie distale



Mal perforant plantaire

Diabètique +++



# Ulcération plantaire



# Ulcération nécrosante



Infection
massive du pied

Atteinte du talon

Amputation +++

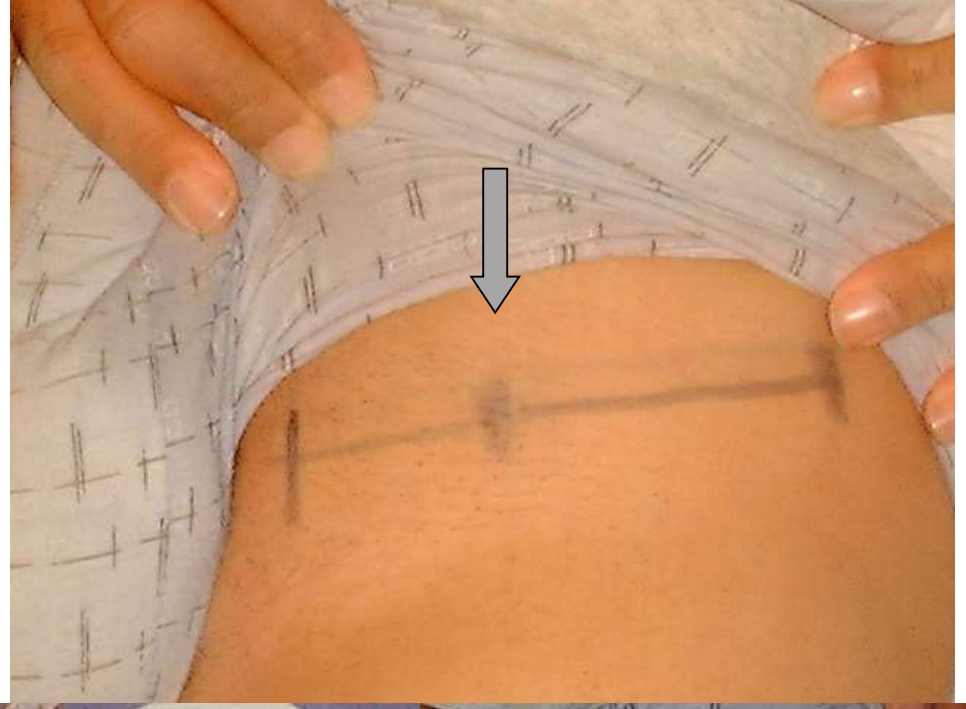
# Examen clinique :

## PALPATION :

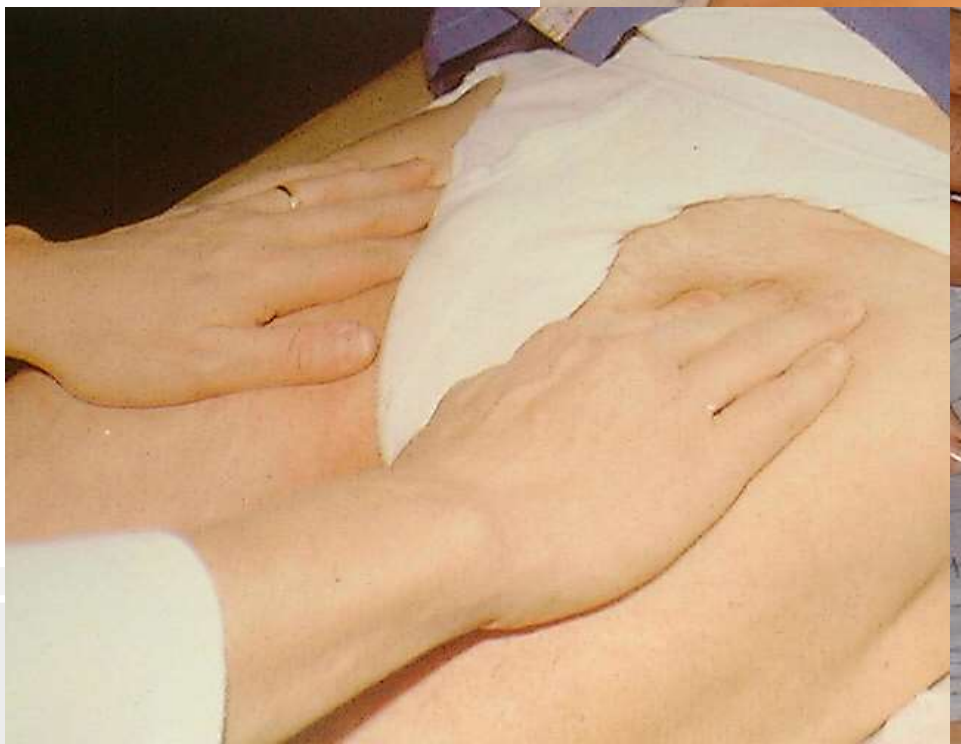
Apprécier la **chaleur locale** : la peau est plus froide que normalement dans l'insuffisance artérielle.

- peau sèche, squameuse, dépilée ; peau fine, fragile, luisante ou au contraire fripée, plissée, sèche par atrophie du tissus sous-cutané.

**Palpation des artères** : examen des pouls aussi bien du membre supérieur que l'inférieur, à la recherche d'une diminution ou abolition d'un pouls.



Pouls fémoral









Pouls poplité





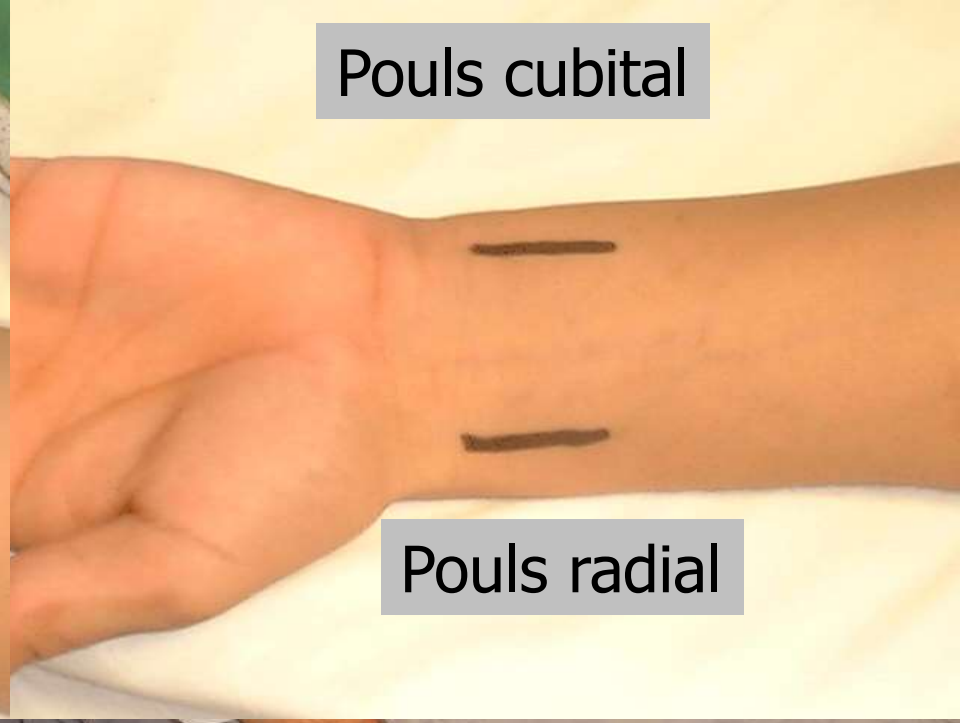

Pouls pédieux


Pouls tibial post






Pouls huméral


Pouls cubital
Pouls radial







Pouls axillaire

Creux axillaire

# Examen clinique: Palpation

- Douleur à la palpation.

- Palpation d'une masse d'origine artérielle ( masse battante, soufflante, expansive).

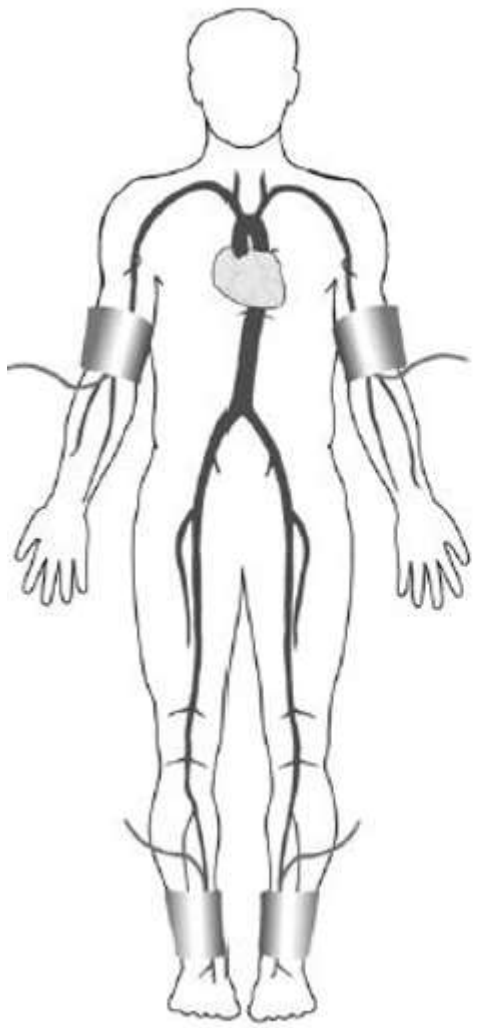
**Prise de l'index de pression systolique** : IPS

la mesure de la tension artérielle se fait au deux bras et les deux jambes. Une tension systolique du membre inférieur < tension systolique membre supérieur est suspecte d'une insuffisance artérielle.

$$\textbf{IPS} = \frac{\text{P.A.S distale du membre inférieur}}{\text{P.A.S humérale}} \qquad N(0,9\text{-}1,2)$$

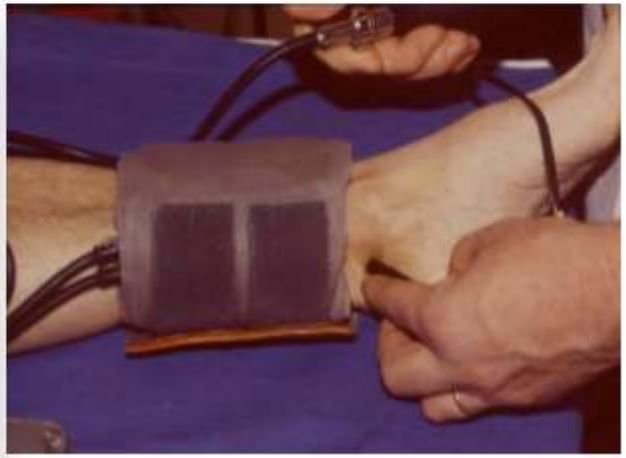
# IPS

**« Un geste Important Pour la Santé »**



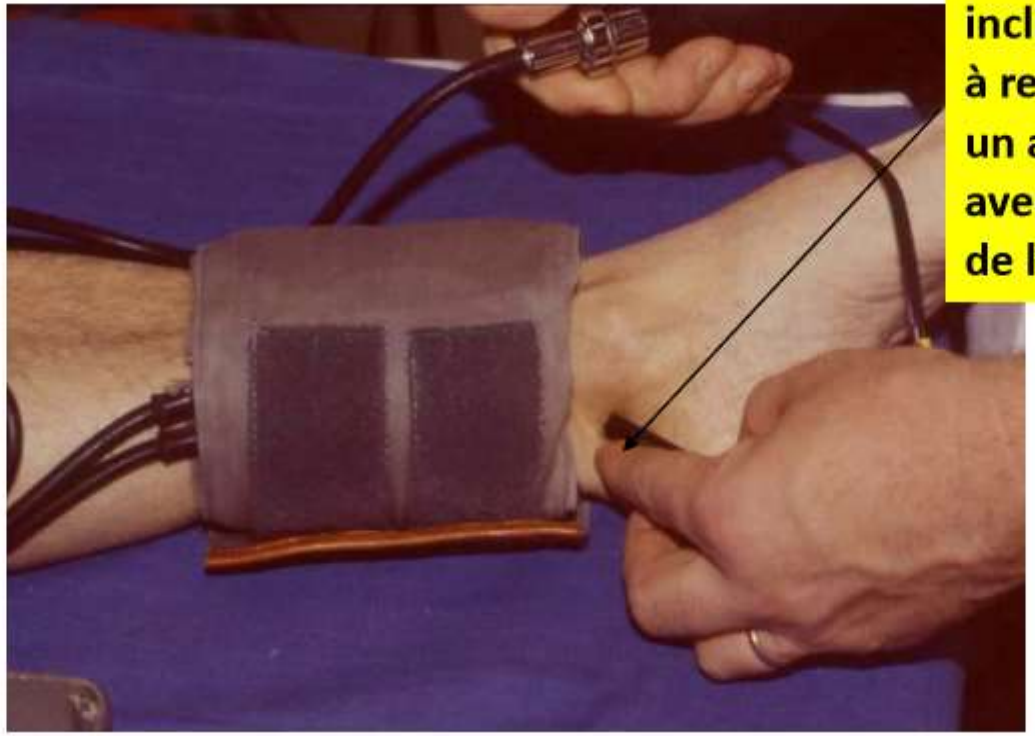
Rapport entre : $\frac{\text{pression systolique cheville}}{\text{pression systolique bras}}$





# Règles de base

Sonde doppler inclinée de manière à respecter au mieux un angle θ de 45-60° avec l'axe présumé de l'artère examinée

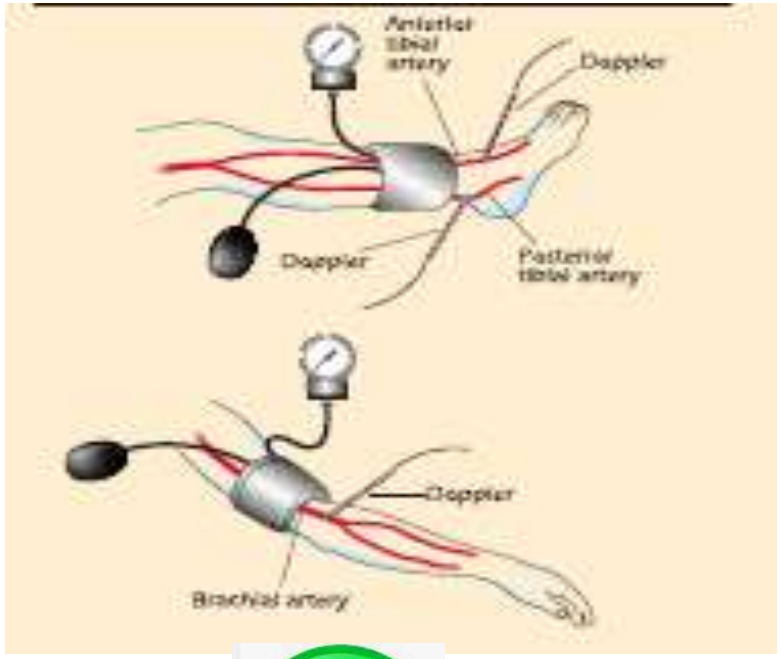


Tuyaux sortant vers le haut

Manchette affleurant les malléoles, ajustée à la cheville, enroulée sur elle-même



# Brassard mal placé IPS faussé






| | |
|---|---|
| 1 - 1,3 | Normal |
| 0,75 - 1 | Artériopathie compensée |
| 0,50 - 0,75 | Artériopathie mal compensée |
| < 0,50 | Artériopathie sévère |

# Examen clinique : Auscultation:

Sur le trajet artériel :

- Rechercher un souffle systolique de sténose artérielle peut s'accompagner d'un frémissement palpable.

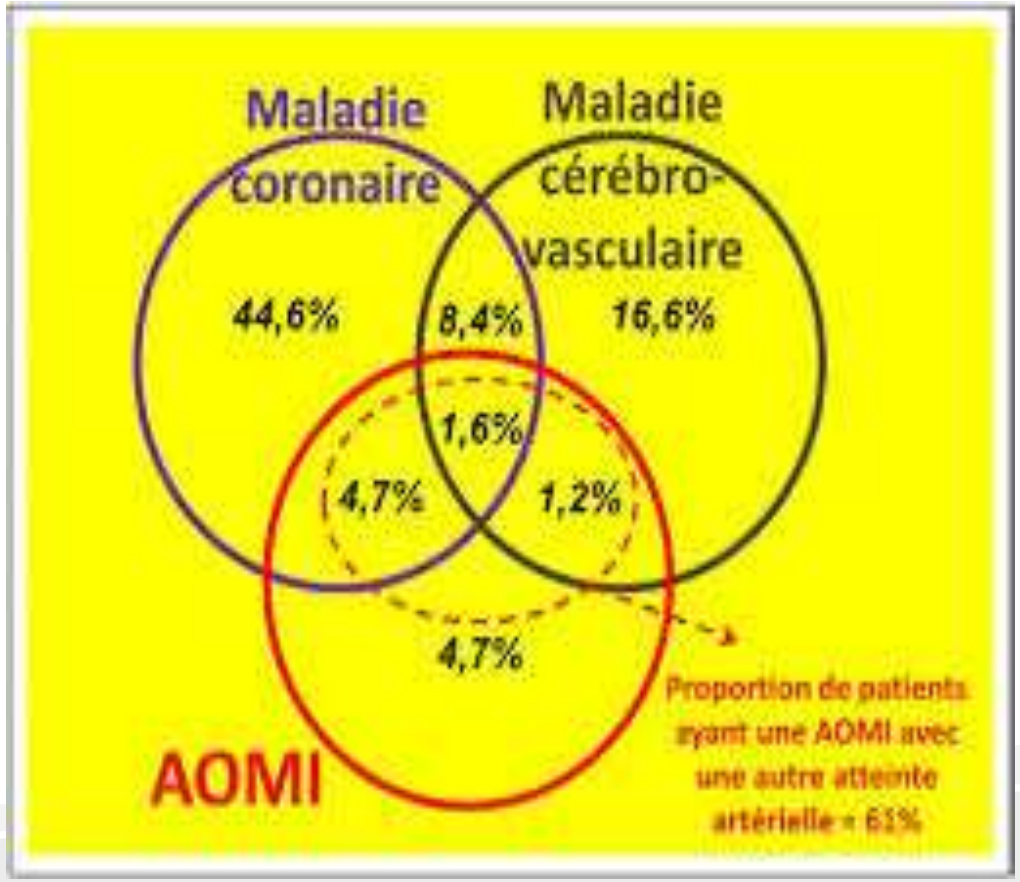
- Rechercher un souffle continu traduisant une fistule artério-veineuse.

examen des autres trajets artériels :

cervical – membres supérieurs – abdomen.

examen de l'abdomen ( masse palpable, C.I digestive.

- <u>EXAMEN DES AUTRES APPAREILS</u>
  - cœur.
  - carotide.
  - rein.
  - abdomen.



# Explorations vasculaires
# Examens complémentaires :

**Non invasive :**

- Echodoppler

- Angioscanner hélicoïdal

**Invasive :**

- Artériographie

# Exploration vasculaire :

Echo doppler – échographie :

Échographie : Permet l'étude

- morphologique de l'artère (diamètre, épaisseur de la paroi artérielle.
- anomalie de la paroi : sténose, plaque, calcification, dissection (flap intimal).
- un anévrisme (fusiforme ou sacciforme)

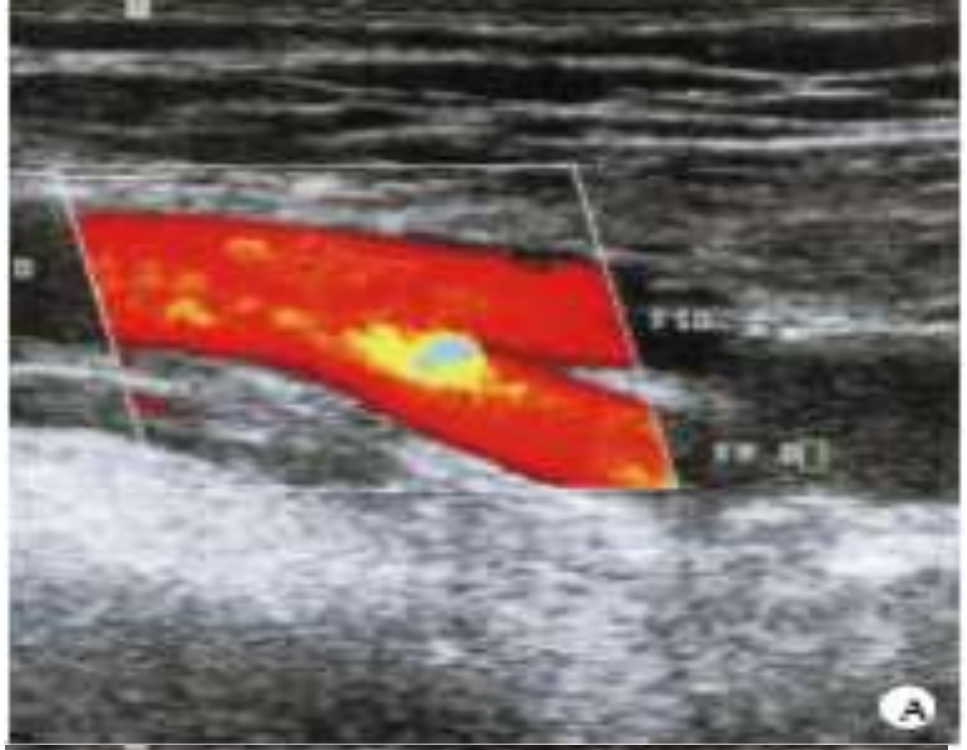
Doppler : permet une étude des vitesses circulatoires (systolique et diastolique), le débit d'amont et d 'aval,

- Facile à réaliser, moindre coût, répétitif non douloureux mais exige un opérateur entraîné et qui maîtrise la pathologie vasculaire.
- Examen opérateur dépendant.

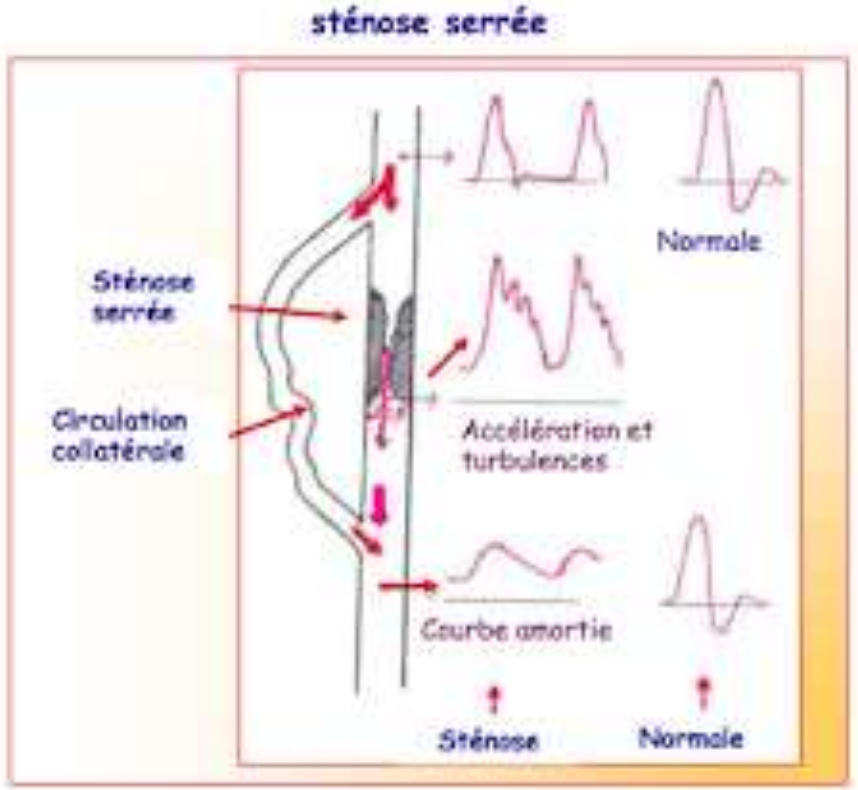


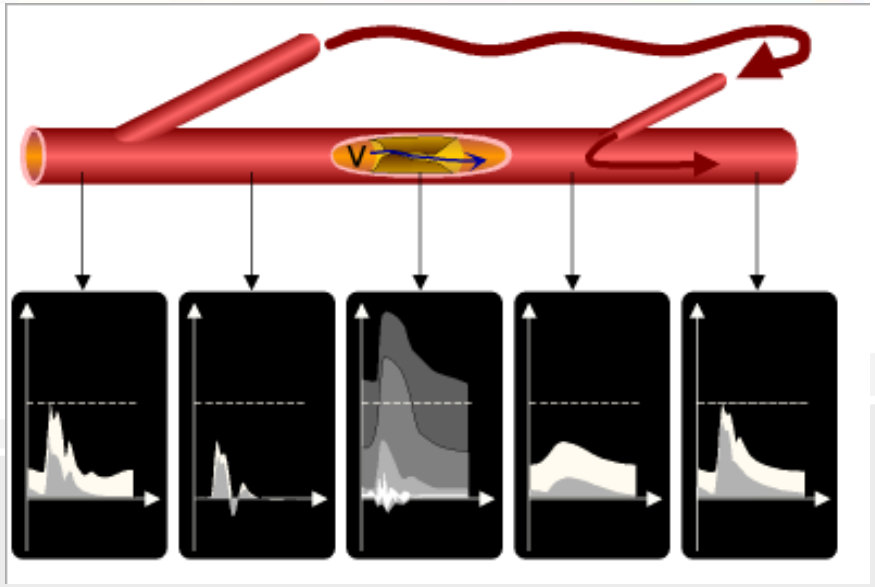


# Dépistage diagnostic


A


B


sténose serrée
Normale
Sténose serrée
Circulation collatérale
Accélération et turbulences
Courbe amortie
Sténose
Normale


V



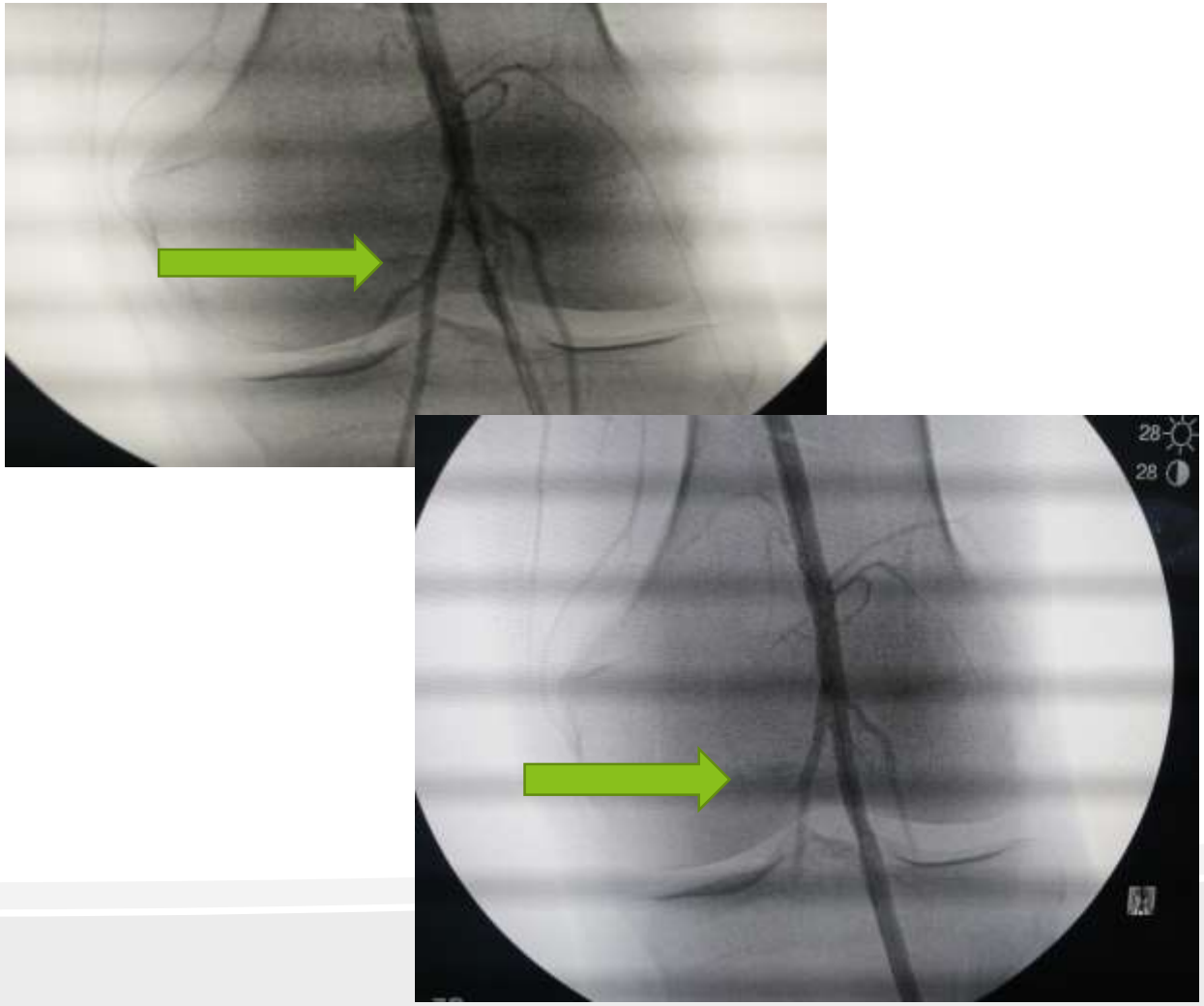

# Coupe transversale échographique d'un AAA

# Explorations vasculaires:

Artériographie :

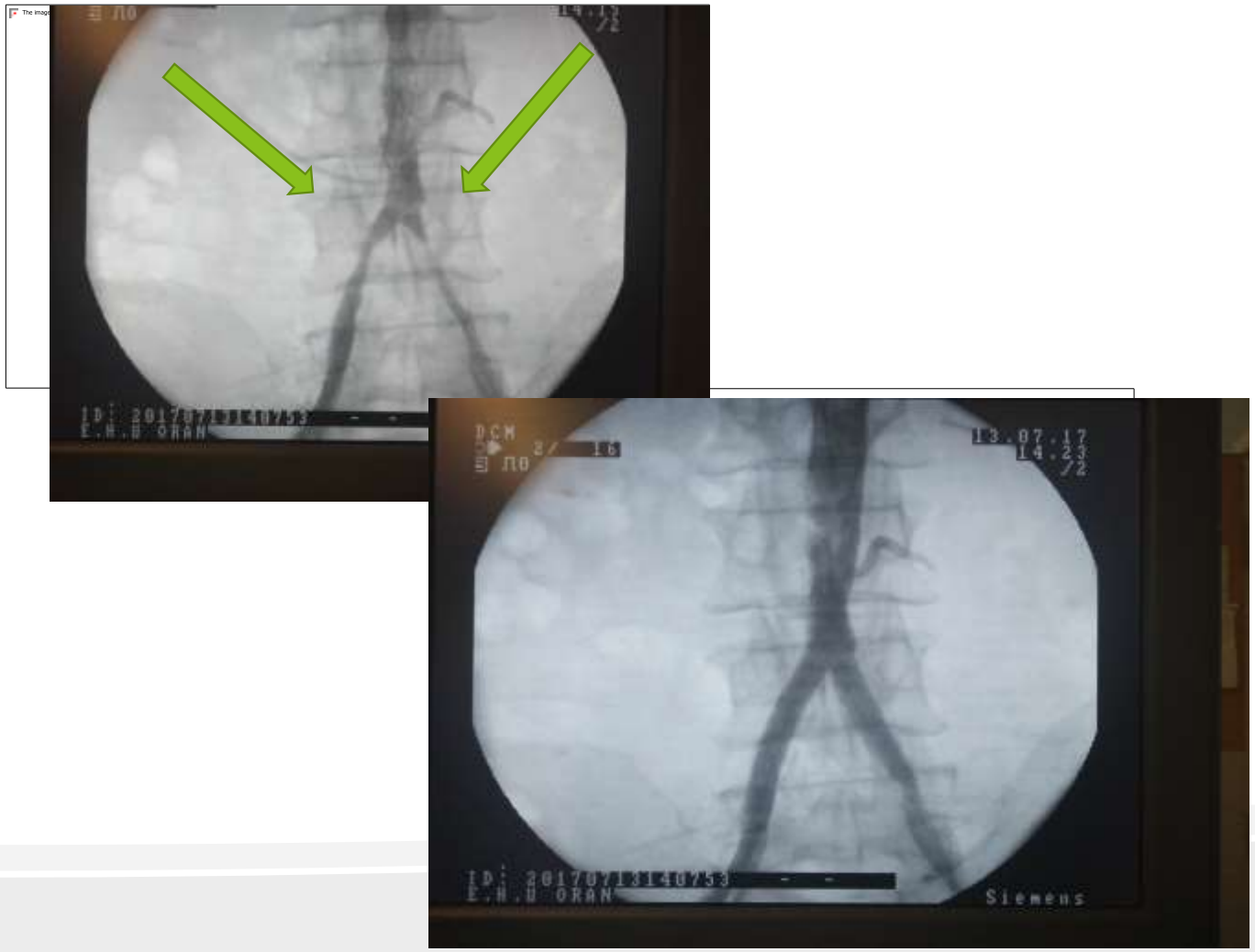
Examen invasif, permet une opacification des trajets artériels par ponction transcutanée directe des artères soit par voie fémorale ou humérale.

Sémiologie : rétrécissement (sténose), une obstruction (thrombose), appréciation du développement d'une collatéralité en aval d'une sténose, état du lits d'aval, fuite de produit de contraste (faux anévrisme), anomalie de la paroi ( remaniement athéromateux), existence d'un retour veineux précoce (FAV).



# Artériographie

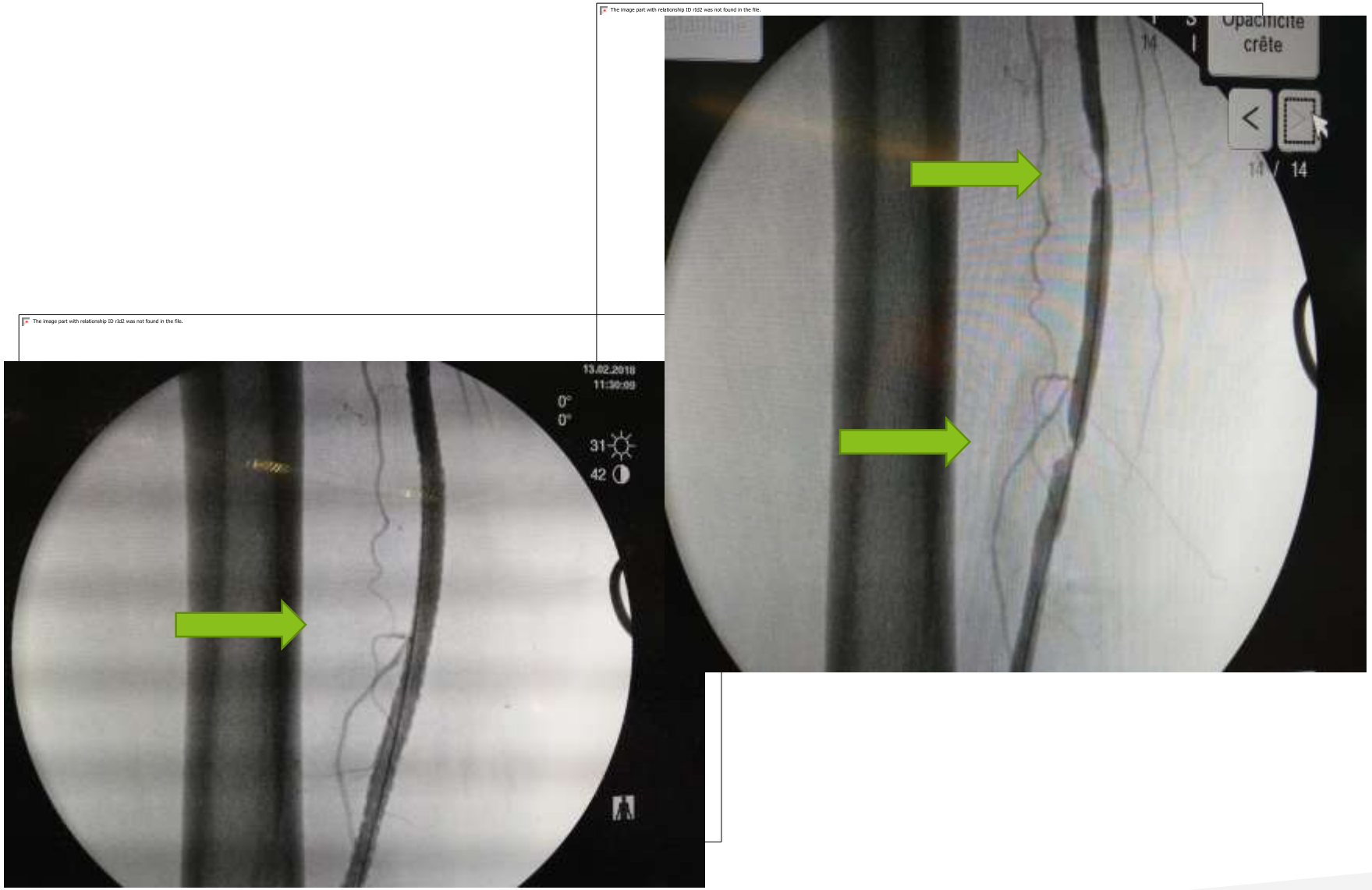
## Sténose serrée poplité traitée par ATL



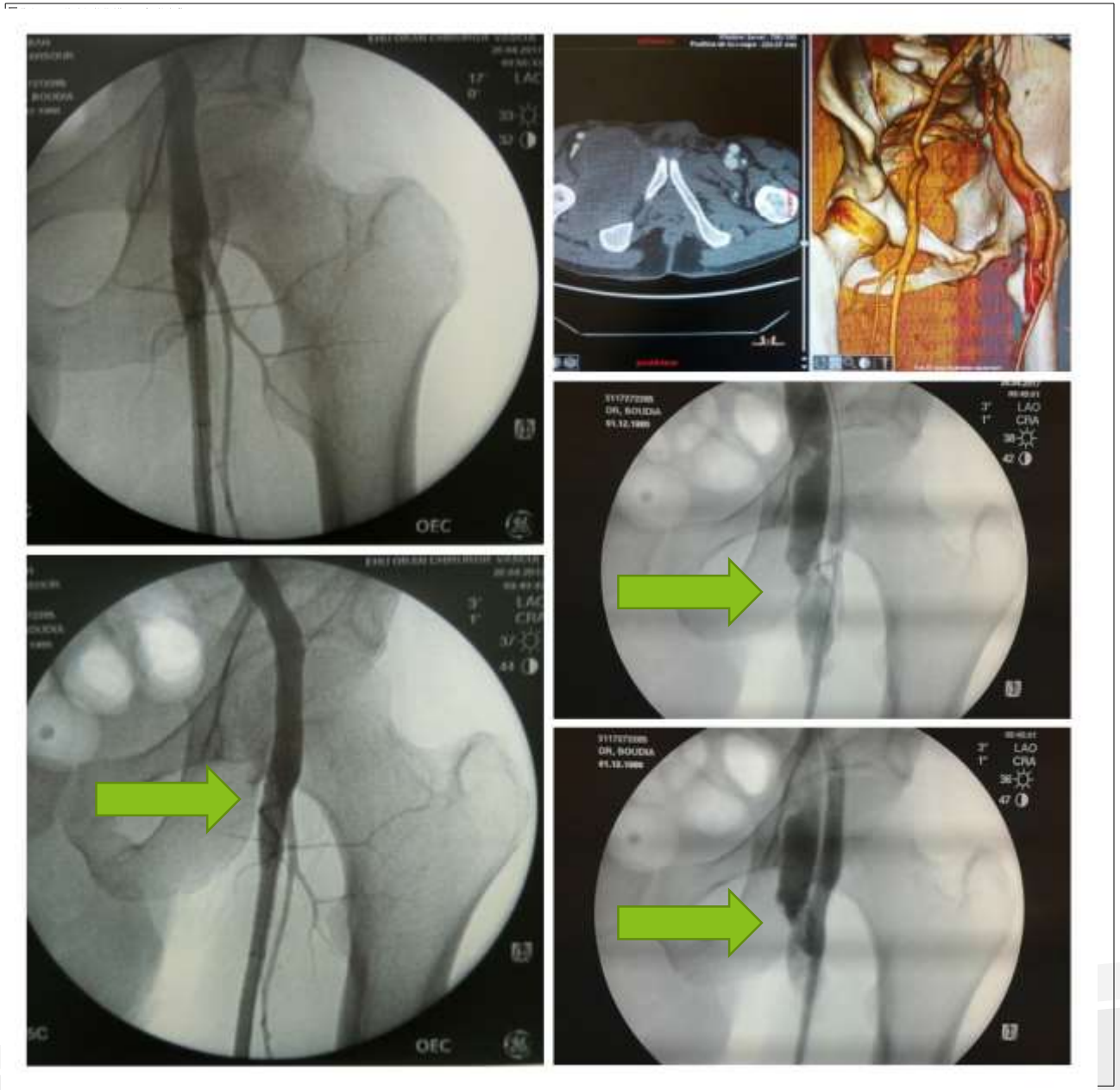

# Artériographie

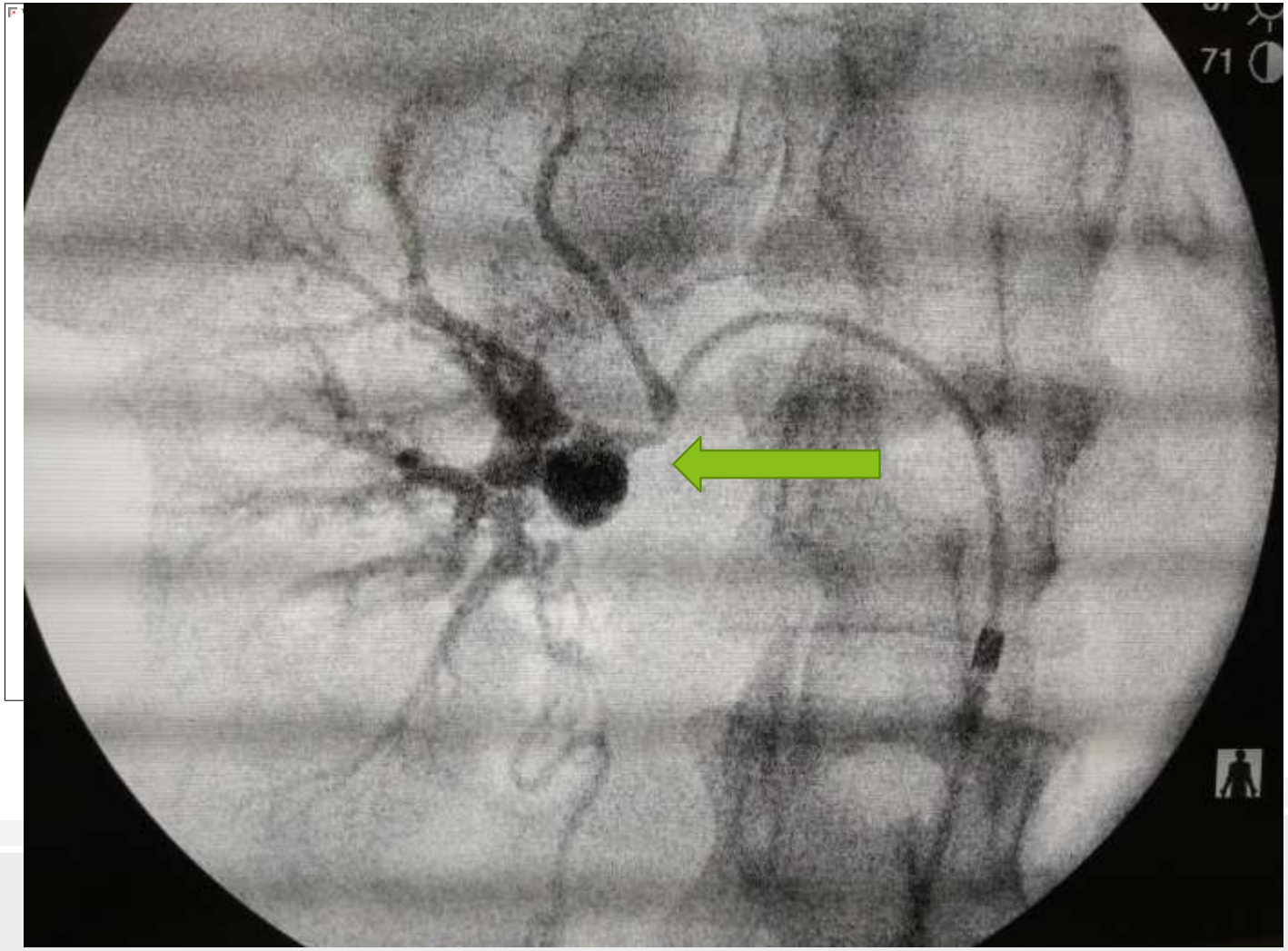
## Sténoses bi-iliaque commune traitée par kissing stent

# Sténoses étagées de L'AFS traitées par ATL STENTING

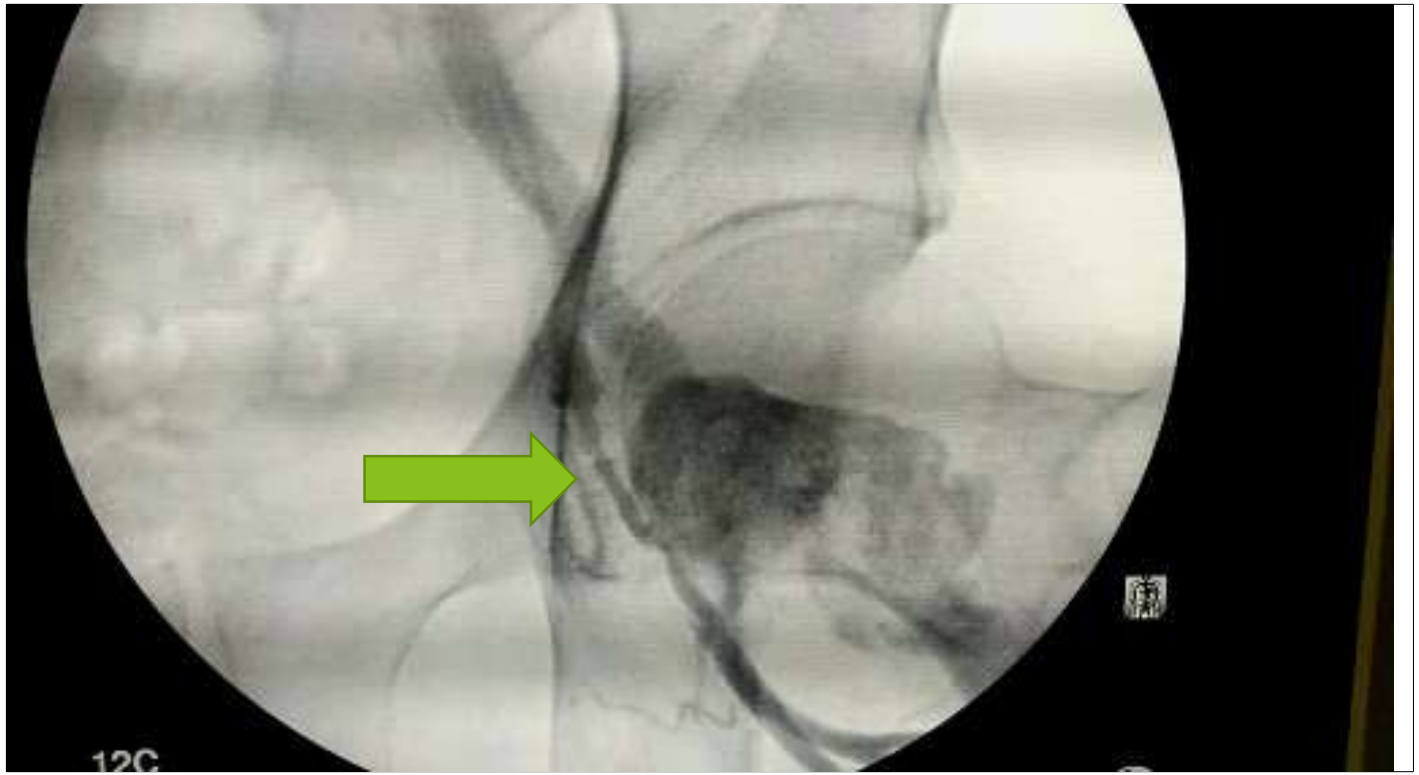


FAV post traumatique
Entre l'AFS et la VFS
Traitée par un Stent couvert





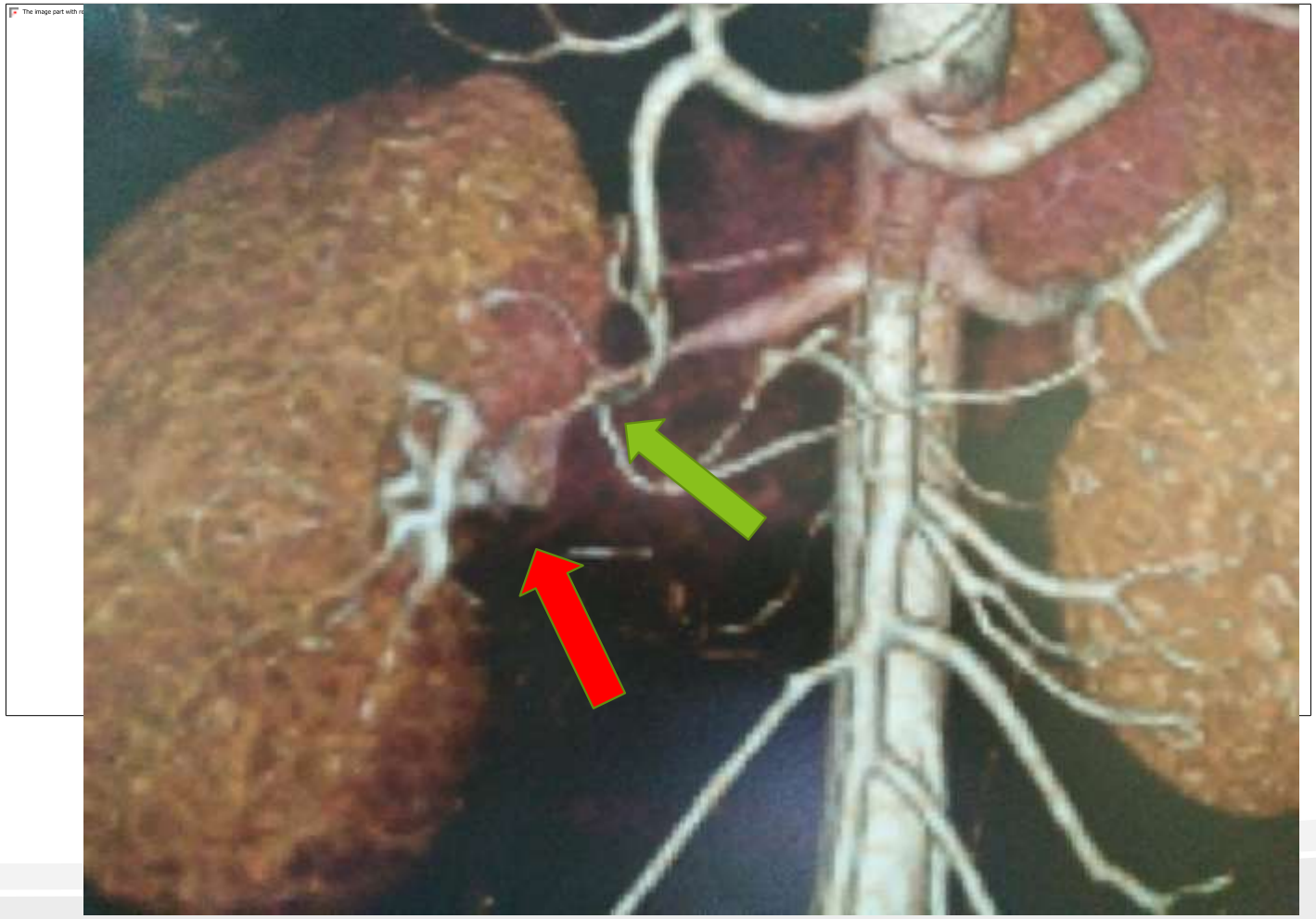

# Artériographie: Faux anévrisme de l'artère rénale droite



# Artériographie: Faux anévrisme de l'AFC Gauche

# AngioTDM ou Angioscanner:

- A supplanté l'artériographie, vu son caractère non invasif
- Demander de première intention lorsqu'un traitement chirurgical de revascularisation est prévu
- Permet le traitement et la reconstruction des images
- Inconvénient : Injection de PDC nocif pour les reins
- Préparation rénale préalable+++
- Sinon ANGIO-IRM



AngioTDM:
Image de reconstruction

Sténose tubulaire de l'A.Rénale droite

Avec dilatation post sténotique




# AngioTDM

## Sténose serrée de la carotide commune droite




# AngioTDM:

## Anévrisme poplité bilatéral thrombosé à gauche



# Les anévrismes artériels

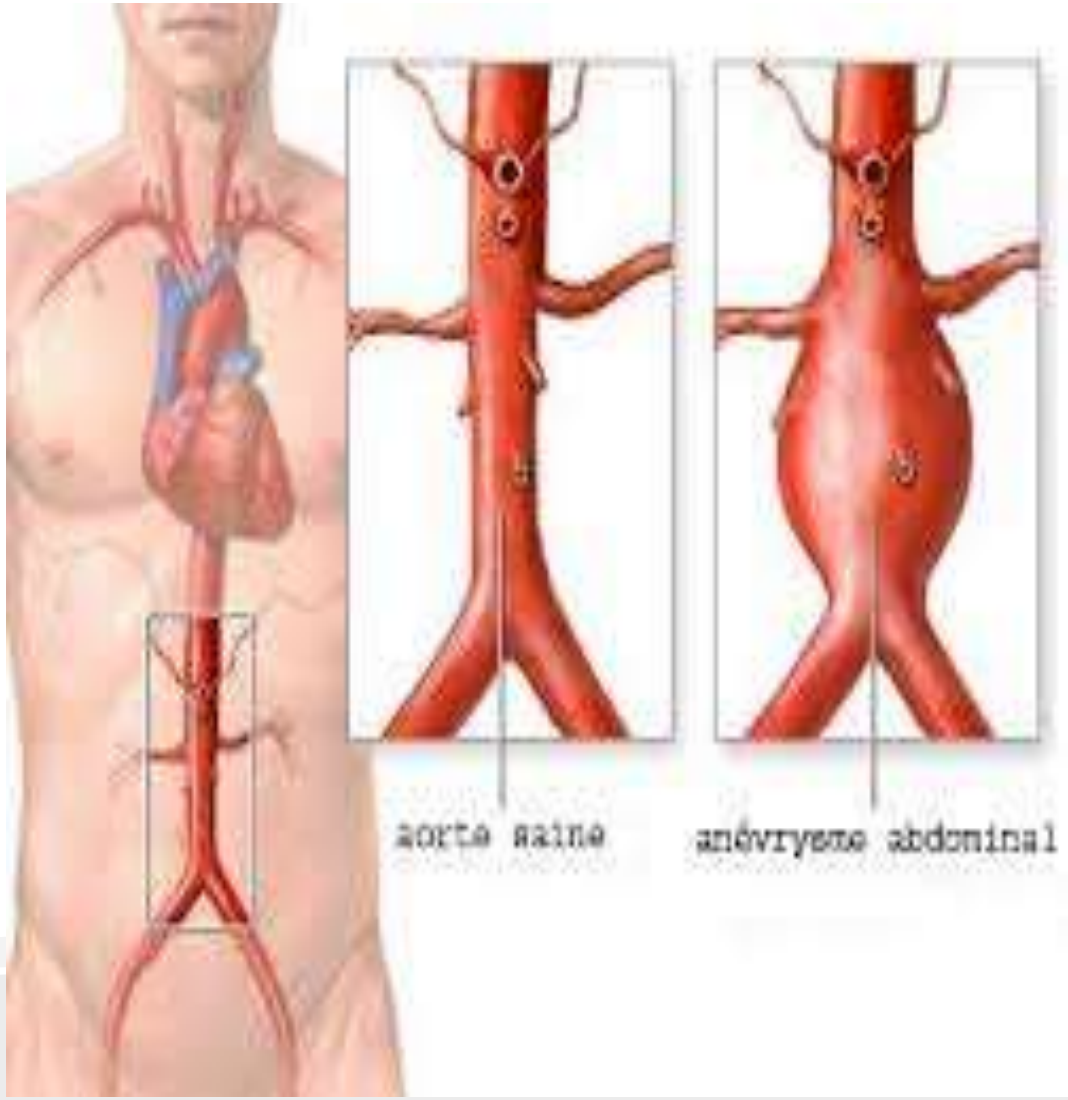
# DEFINITION

Dilatation permanente et localisée de l'artère avec une perte du parallélisme de ses parois.

**Augmentation d'au moins 50% de son diamètre par**

**rapport aux chiffres normaux de l'artère considérée**

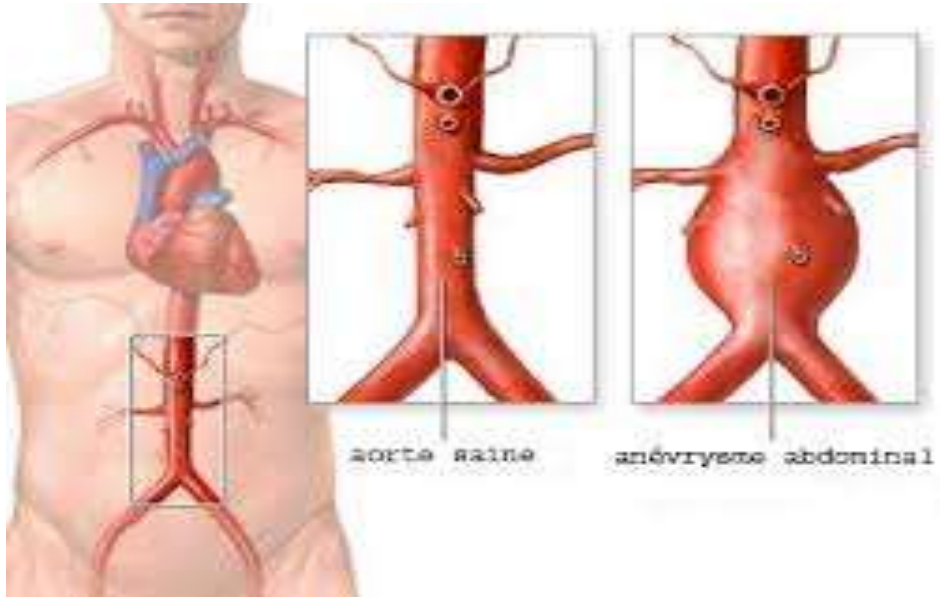
(définition de la Société Nord Américaine de chirurgie vasculaire).

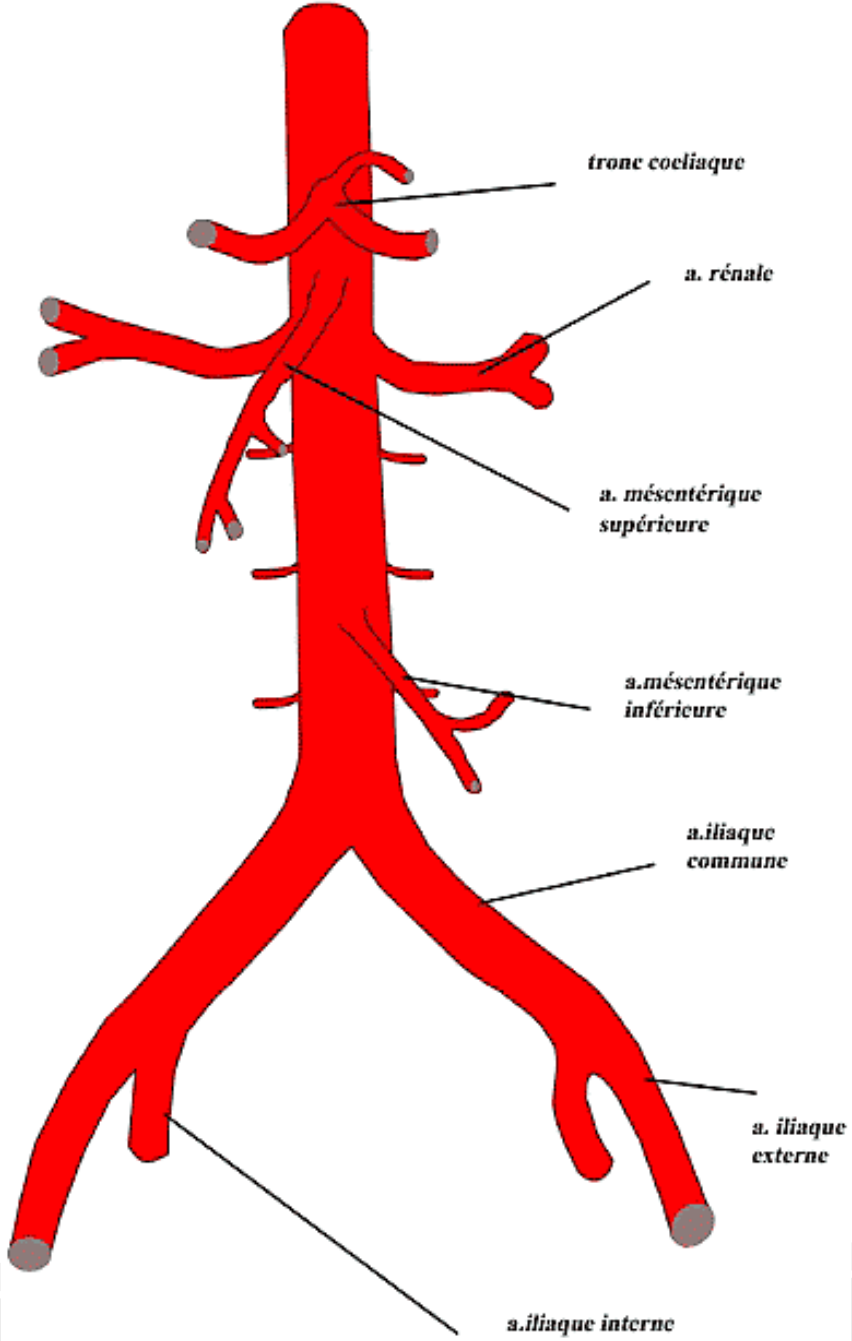


# Rappel anatomique

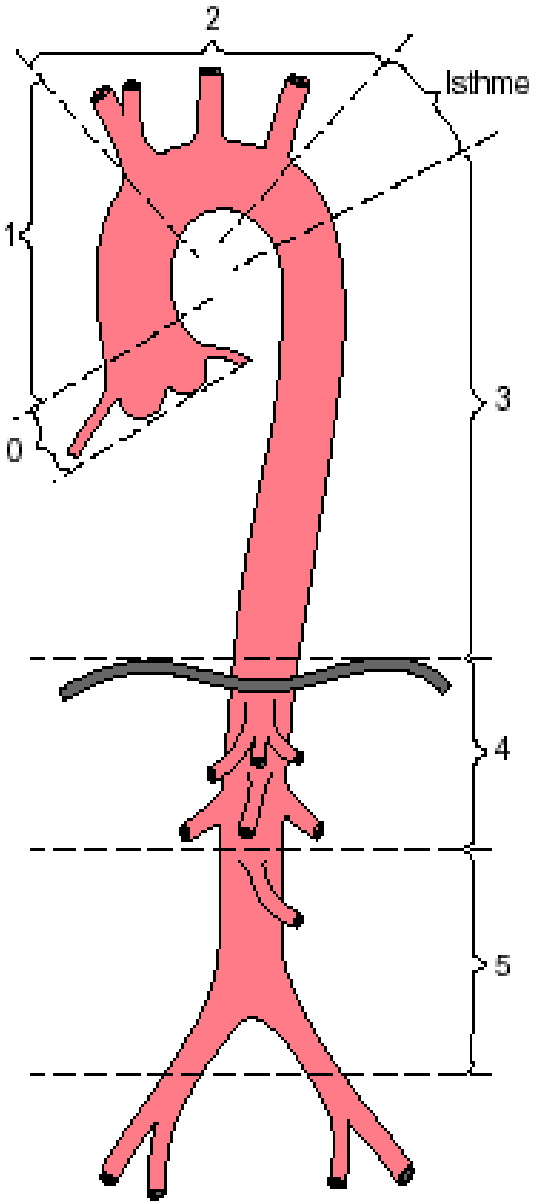
Le diamètre normal  1.2 à 2.2 cm

1.4 à 2.4 cm chez l'homme





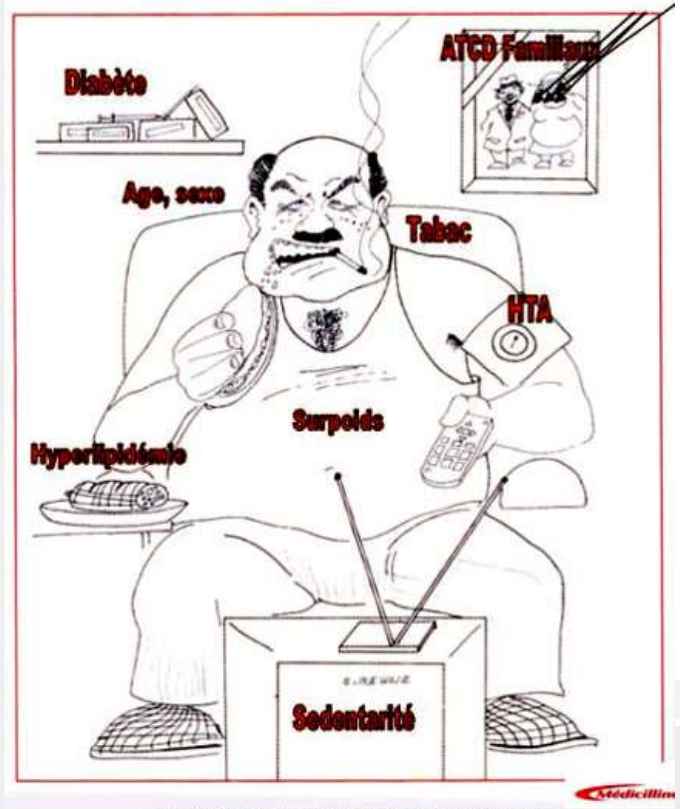

Aorte abdominale et ses branches




1 *Représentation schématique d*
*l'aorte et de ses différents segments.*

# Etiologies

- L'athérosclérose est la principale cause d'anévrysme (90%).




Dessin 1.Facteurs de risque de l'athérosclérose
(D'après « IDE Mémo » Béliard, Prunier, Revue, Sabotin, Zagury- Ed Médicilline

# Les autres causes d'anévrysme (10%)

Dystrophies de la paroi artérielle (média) de la maladie de Marfan, maladie d'Ehlers-Danlos.

Artérites inflammatoires (5%) : maladie de Takayashu.

Anévrysmes  infectieux : rares (<2% des AAA)

# Les faux anévrismes (pseudoanévrismes)

*Plaies artérielles franches*

Plaie artérielle latérale sans perte de substance

↓

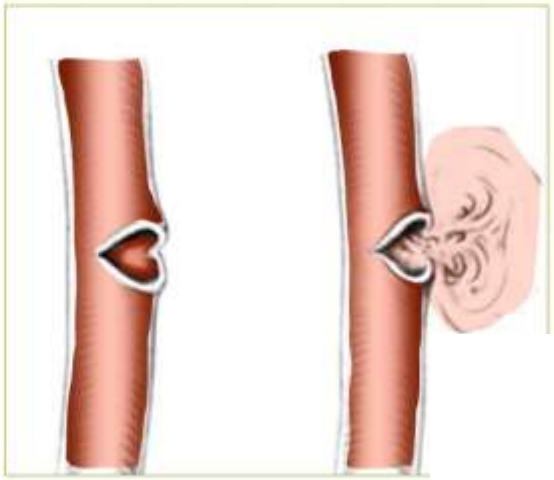
Plaie béante

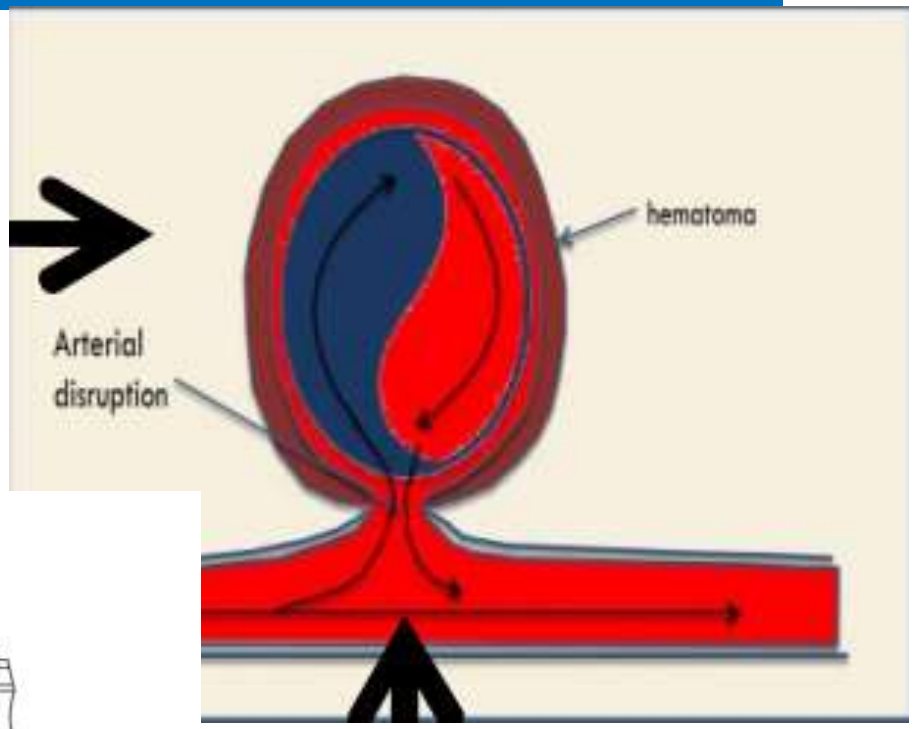
↓

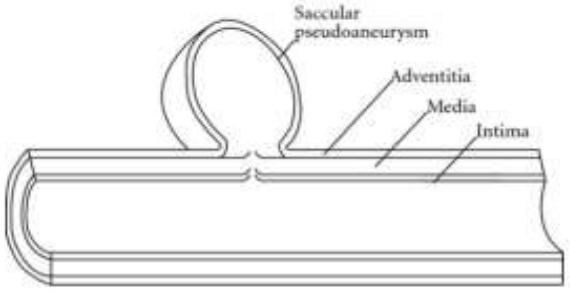
Hématome pulsatile

↓

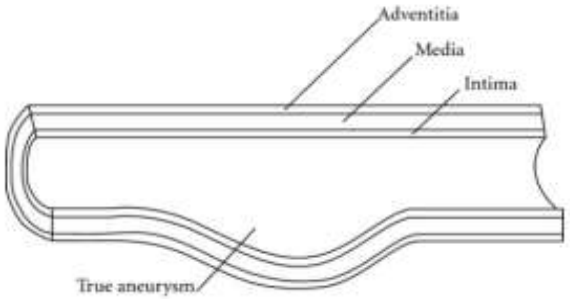
Faux anévrysme






(a)



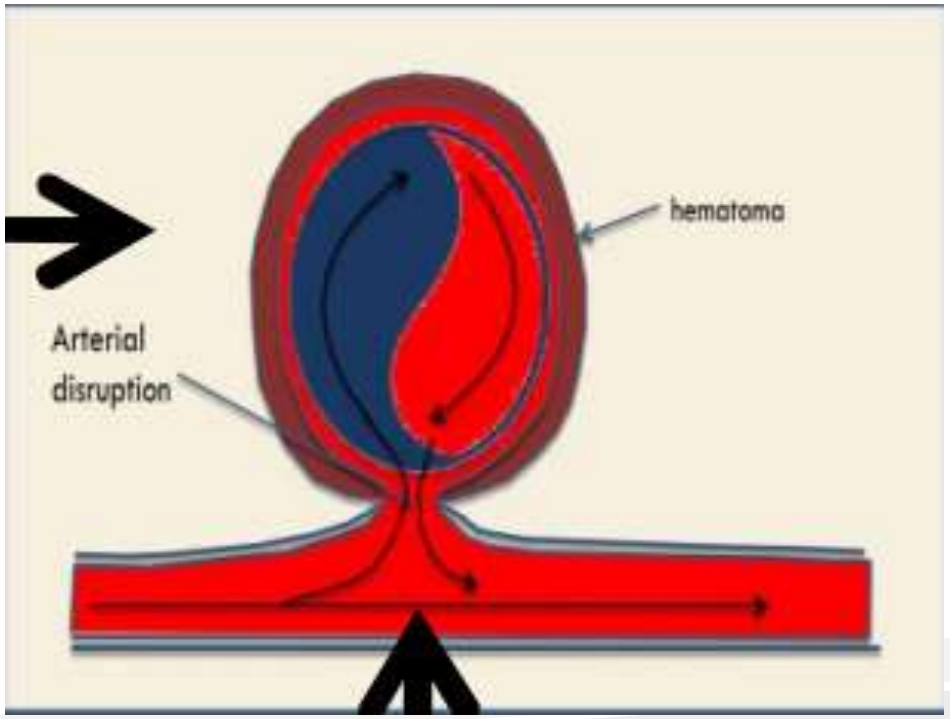
# PHYSIOPATHOLOGIE

- La dilatation artérielle à la loi de Laplace :
  T (Tension Pariétale) = P (Pression Artérielle) x r (rayon de l'artère)

L'accroissement moyen des AAA est de 0,5 cm par an.

Conséquences hémodynamiques : le flux sanguin (laminaire) devient turbulent

→ thrombose intra anévrysmale



# DIAGNOSTIC

# Circonstances de découverte :

le plus souvent asymptomatique.

découverte fortuite échographie abdominale réalisée pour un autre motif (> 70% des cas)

symptomatologie de claudication intermittente des membres inférieurs dans le cadre d'un syndrome de Leriche.

calcifications sur un abdomen sans préparation (ASP)

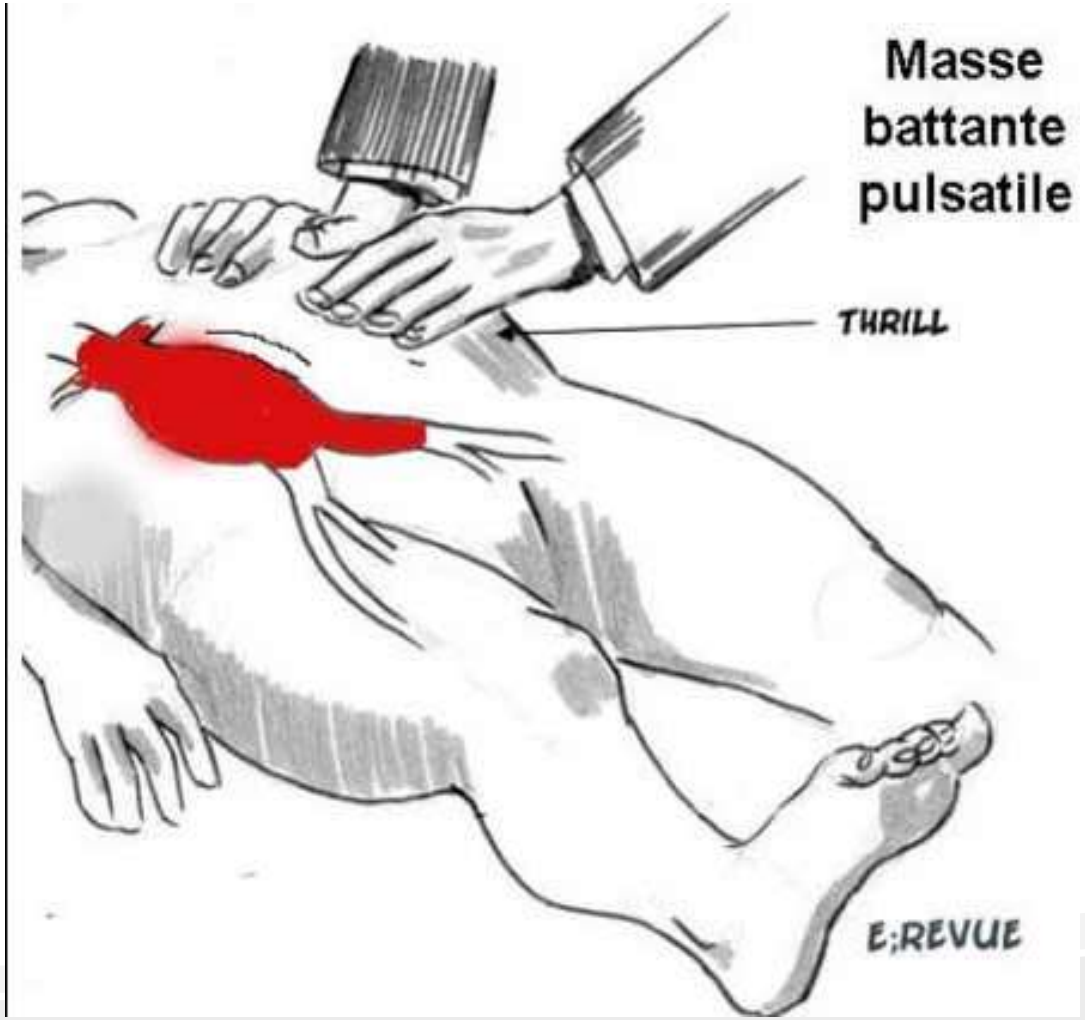
# ***SIGNES FONCTIONNELS:***

- ASYMPTOMATIQUE.
- PARFOIS DOULEUR.

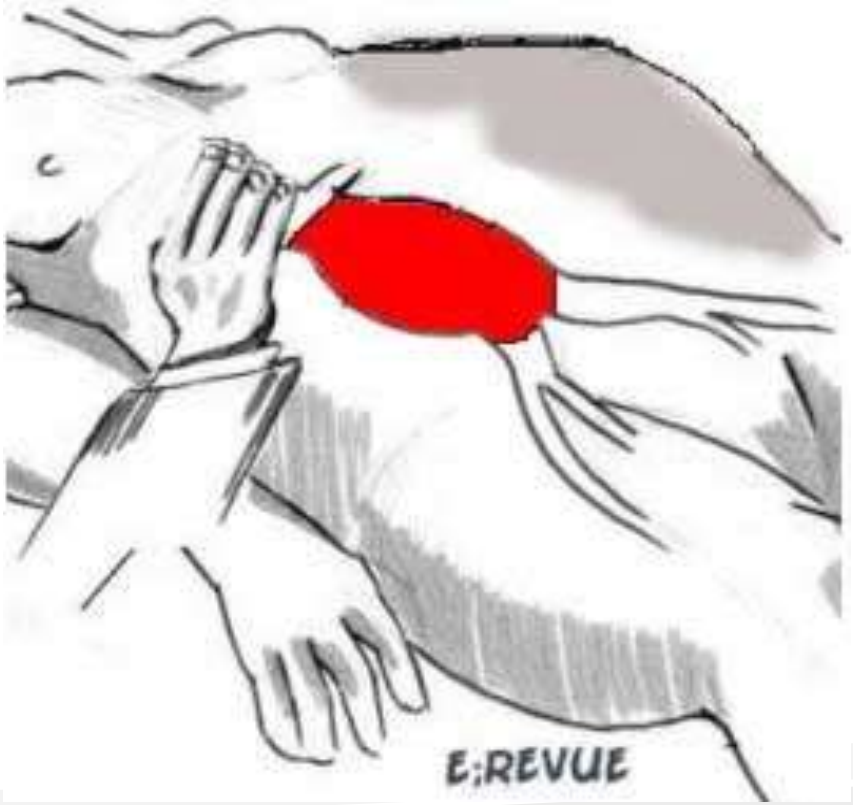
# Examen clinique

## Palpation

- Masse abdominale épigastrique péri et sus-ombilicale médiane battante, expansive et pulsatile (rythmée par le pouls, confirmant le caractère vasculaire) indolore et parfois soufflante (souffle vasculaire à auscultation).
- Expansif lorsque les doigts sont écartés à chaque systole.


Masse
battante
pulsatile
THRILL
E;REVUE

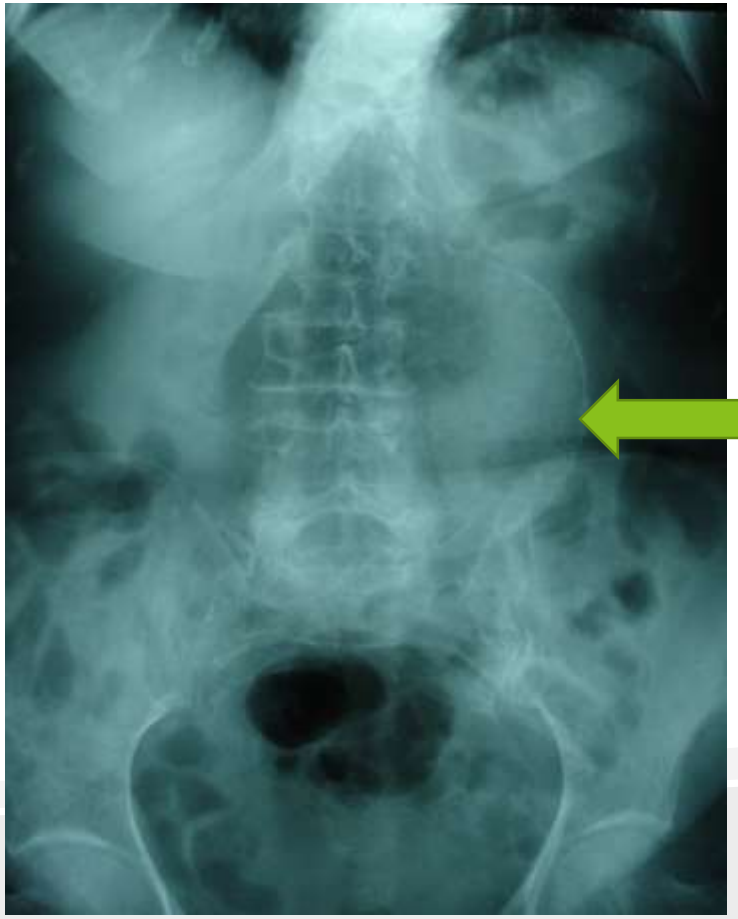
# La localisation sous rénale de l'anévrysme est décrite par le signe de De Bakey



# EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

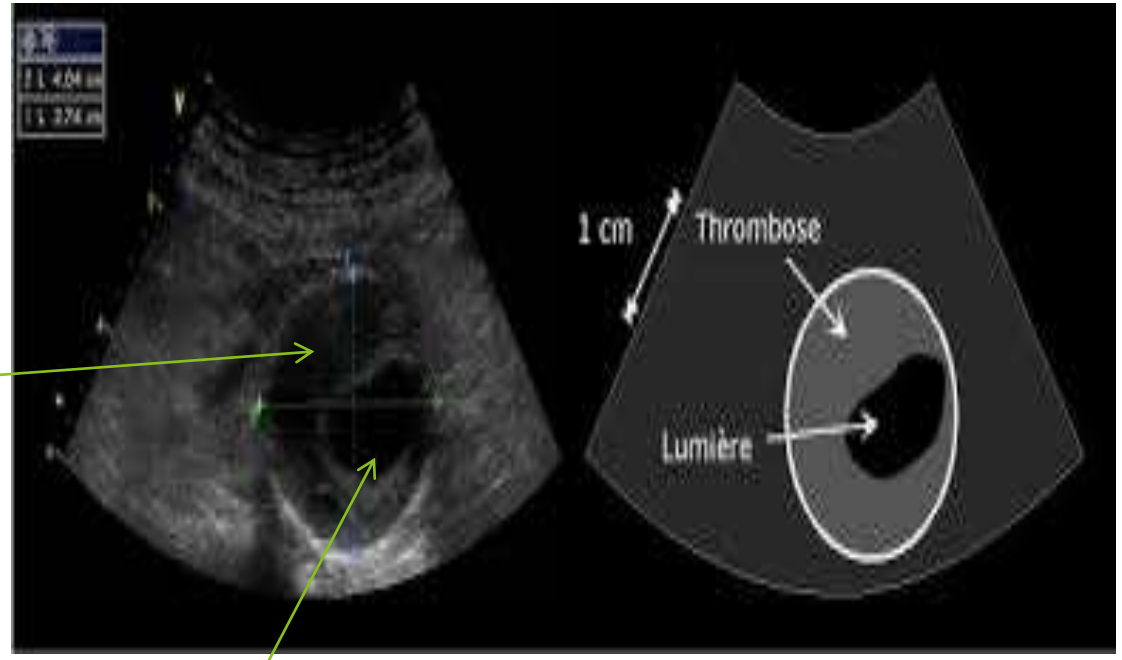
# Abdomen sans préparation

Calcifications dessinant la poche anévrysmale (50%)



Calcifications Pariétales aortiques

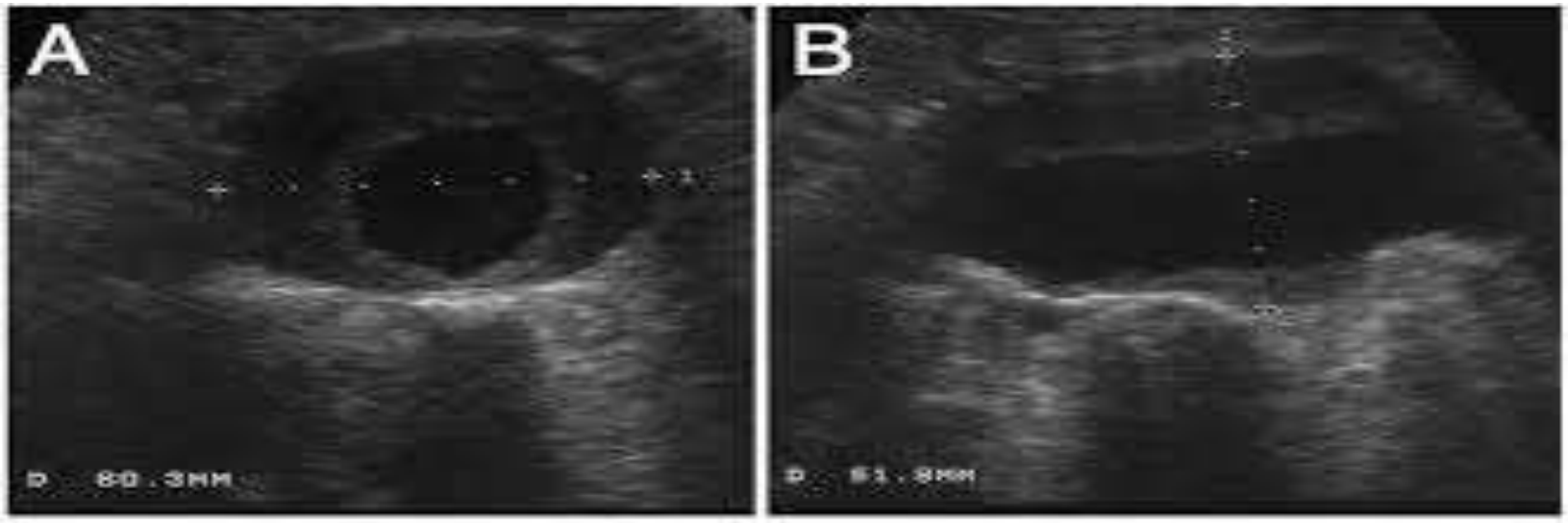
# Echographie abdominale couplée à l'écho-doppler




Thrombus

Lumière circulante

# Echodoppler



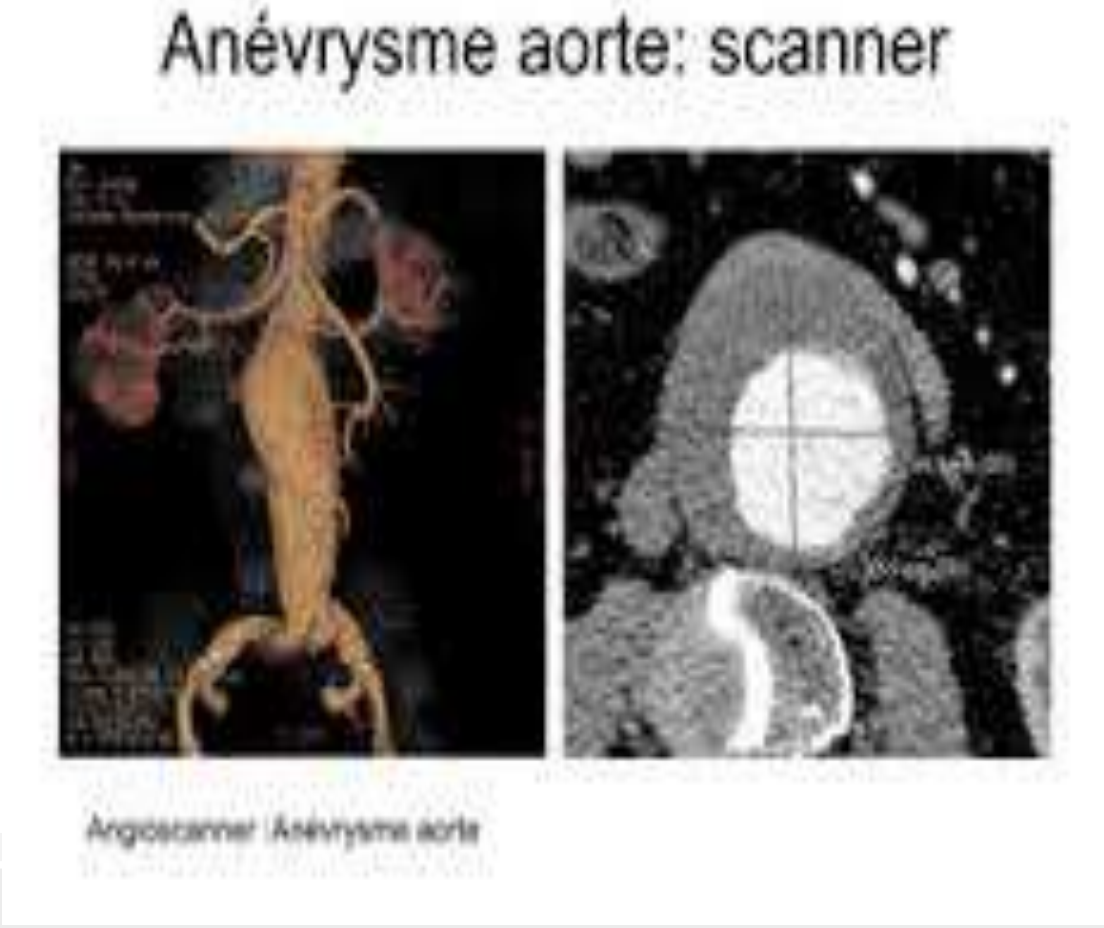

Coupe transversale

Coupe longitudinale

# Tomodensitométrie

- Coupes millimétriques.
- Du cou aux SCARPAS.
- Sizing complet.
- Signes de rupture.

# Angioscanner






# Imagerie par Résonance Magnétique

- L'IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) a les mêmes performances que la TDM

# COMPLICATIONS

# PRERUPTURE :

- lié à la croissance brutale du sac anévrysmal
- l'anévrysme devient douloureux.
- Le risque de rupture est imminent.



# PRERUPTURE : signes

- L'anévrysme devient douloureux spontanément et sa palpation.

- Douleur intense dorsale ou du flanc G ou de la fosse iliaque G. C'est LE piège diagnostique classique de la douleur étiquetée « colique néphrétique » et source de retard dans la prise en charge thérapeutique.



ANEVRYSME DOULOUREUX

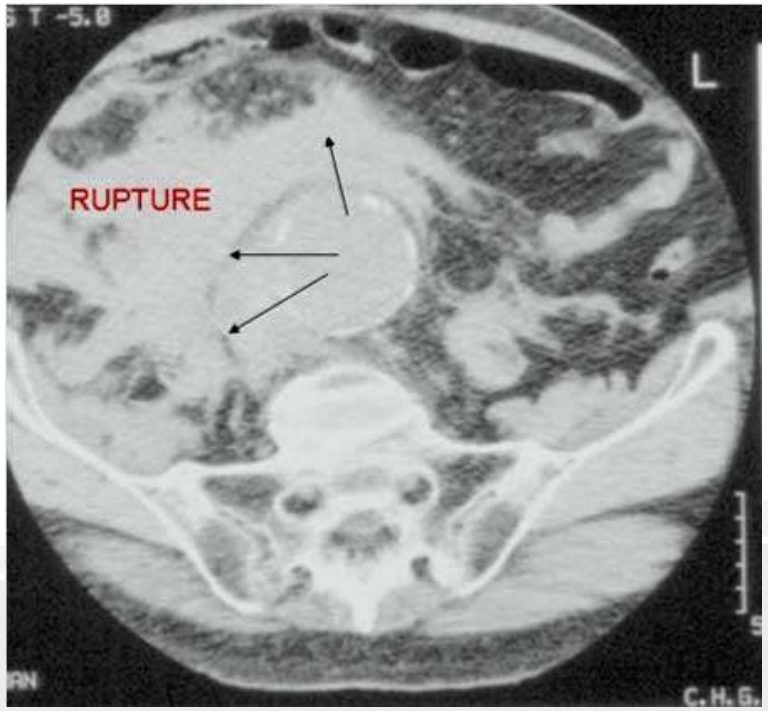


HOSPITALISATION IMMEDIATE EN CHIRURGIE

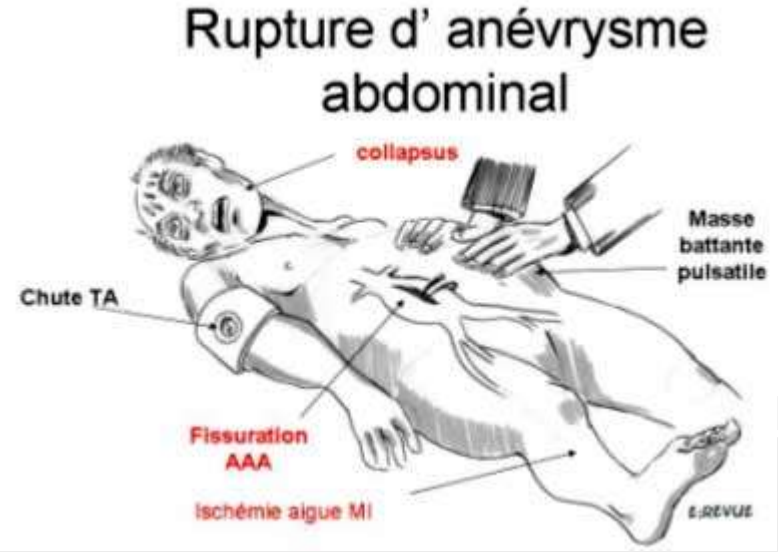
VASCULAIRE

# RUPTURE +++:

- C’est la plus grave des complications.
- C’est une extrême urgence.
- Mortalité globale de 90 à 100 % en l’absence de traitement.



- **Clinique**
- Abdomen est météorisé.
- Douleur++++
- Etat de choc confirme l'hypothèse de rupture.



- Le patient doit être immédiatement transféré en salle opératoire.

# Sémiologie veineuse:

- Thrombose veineuse profonde
- Insuffisance veineuse superficielle

# La Thrombose veineuse profonde TVP

- Définition:

La thrombose veineuse profonde (TVP) est l'oblitération plus ou moins étendue d'une veine par la  constitution et le développement dans sa  lumière d'un thrombus.

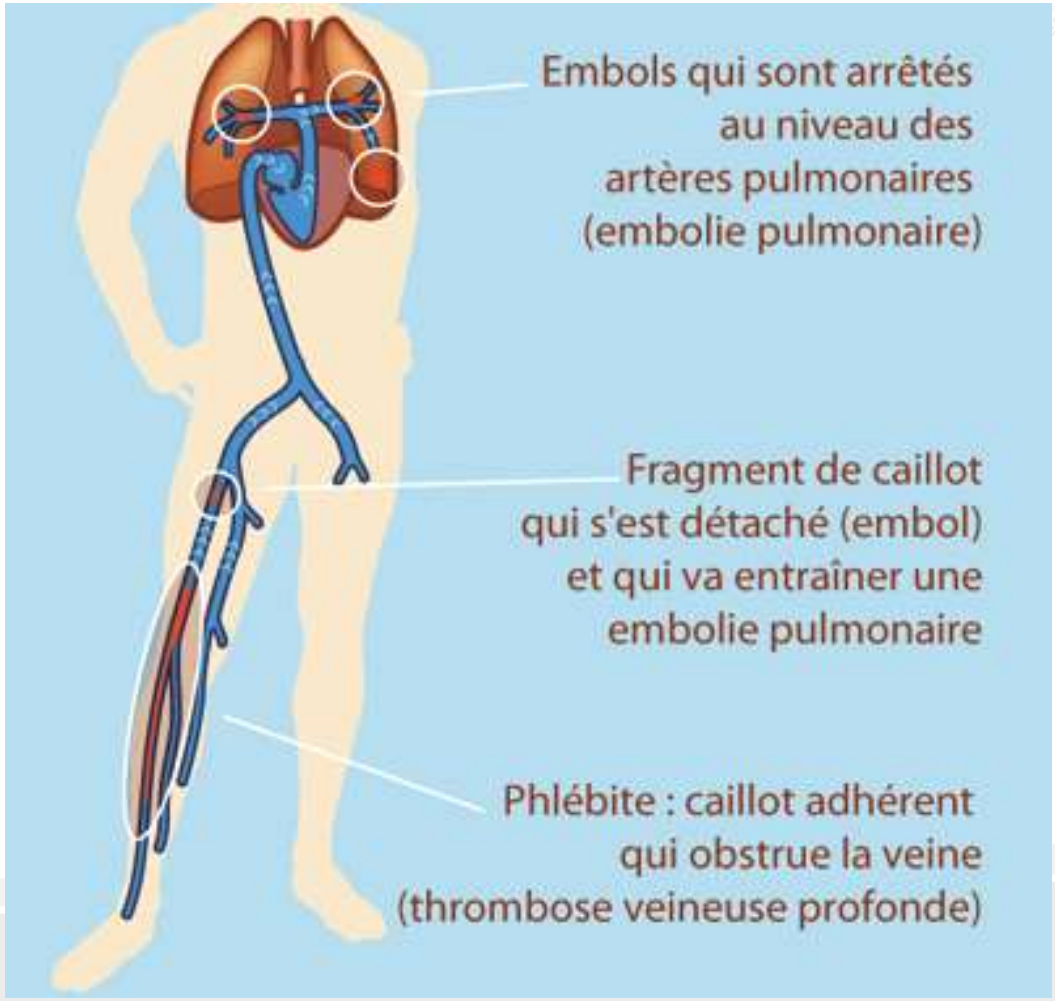


**On ne néglige jamais une TVP**

Immédiat : embolie pulmonaire

Long terme : **maladie** post phlébitique

# Embolie pulmonaire






# Syndrome post phlébitique





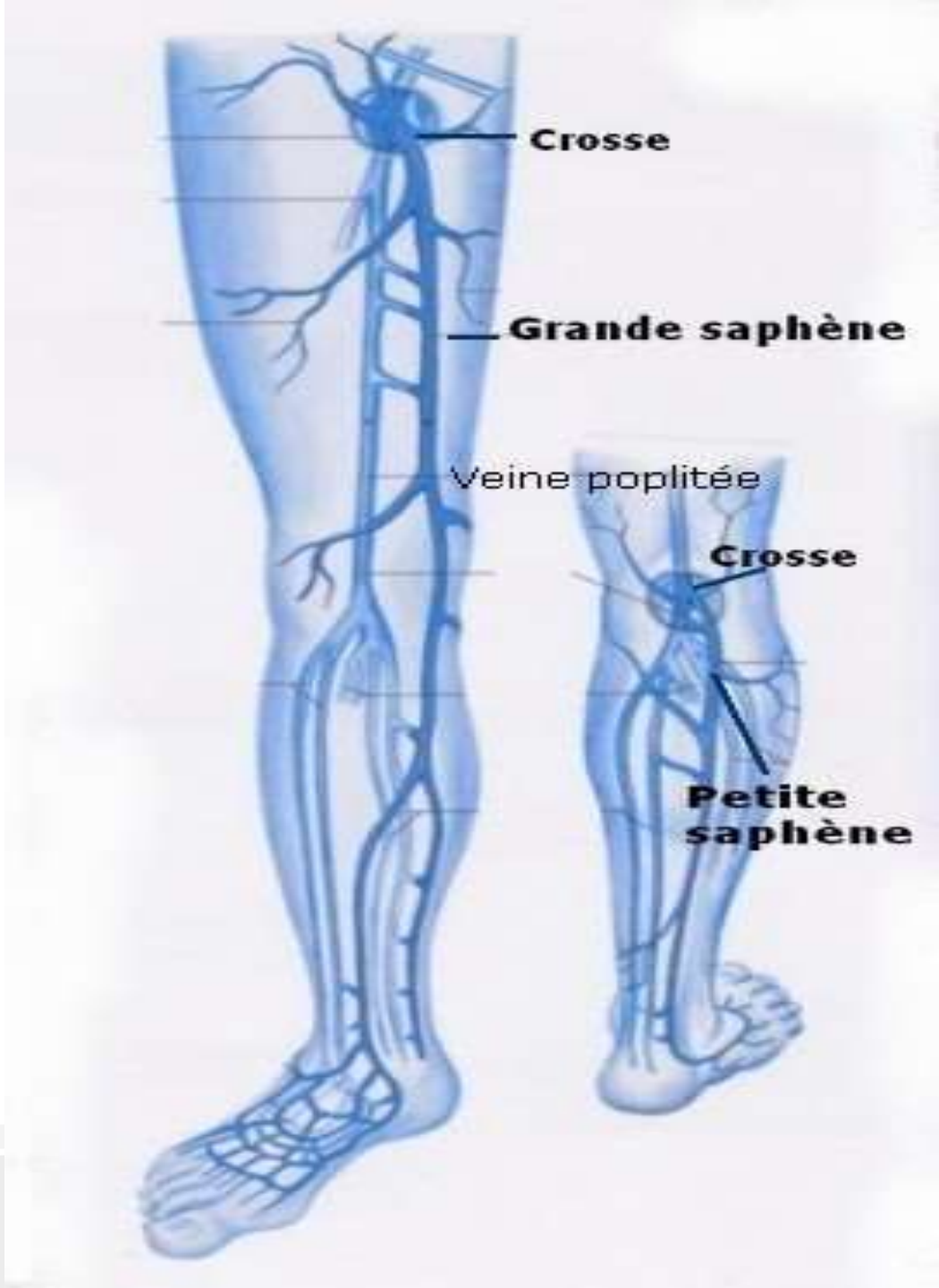
# Rappel anatomique:

- Réseau veineux superficiel : draine 10%

- VEINE GRANDE SAPHENE
- VEINE PETITE SAPHENE

- RESEAU VEINEUX PROFOND : DRAINE 90%

SATELLITE DES ARTERES


Crosse
Grande saphène
Veine poplitée
Crosse
Petite saphène

# PHYSIOPATHOLOGIE



- Selon la triade décrite par Virschow en 1856, 3 facteurs concourent à la formation d'un thrombus :

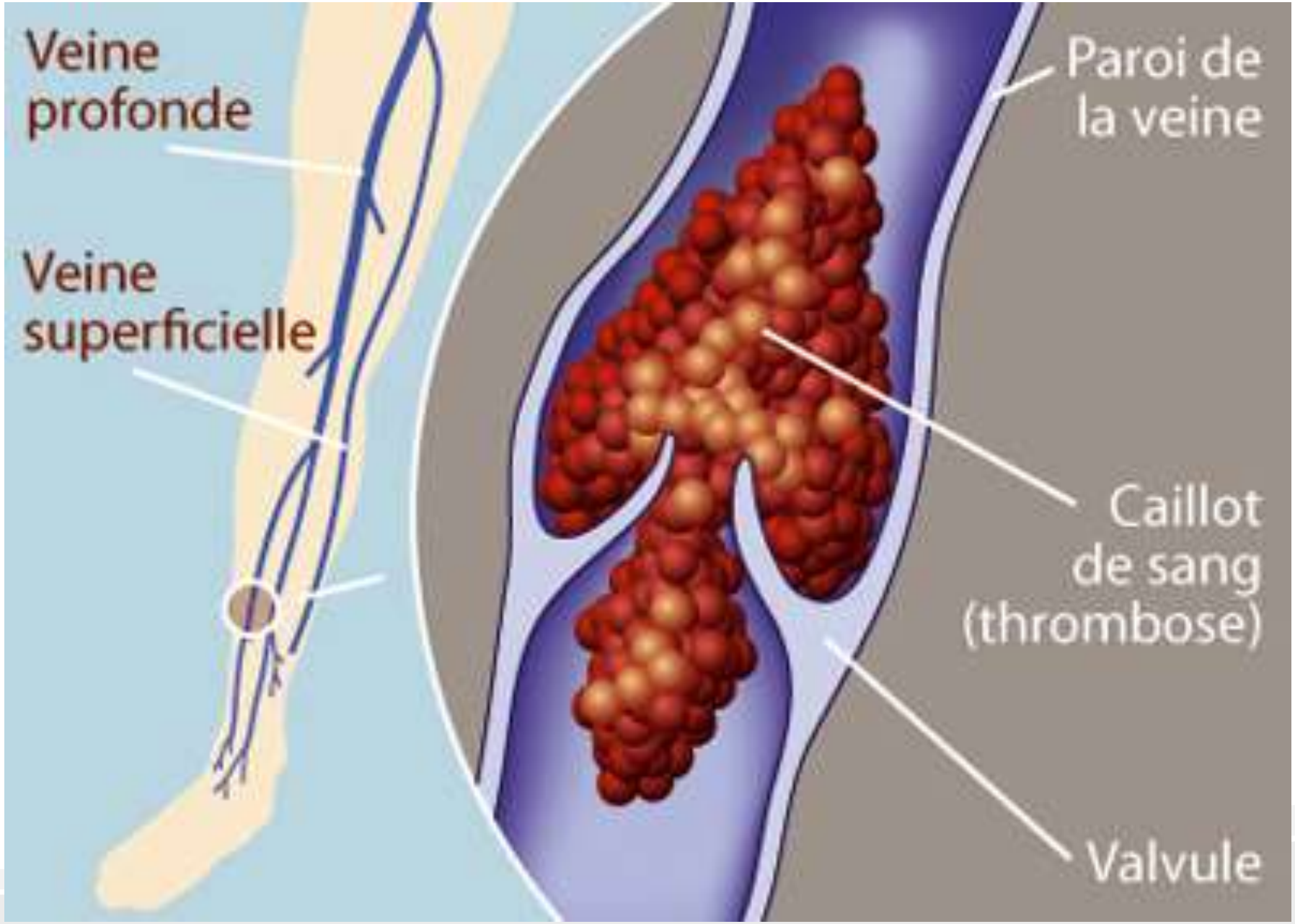
Stase

Altération de la paroi vasculaire

Hypercoagulabilité.

## 3- Hypercoagulabilité

- - ↑ activité facteurs de coagulation
- - Déficit en protéines inhibitrices
- - ↓ fibrinolyse


Veine profonde
Veine superficielle
Paroi de la veine
Caillot de sang (thrombose)
Valvule

# EVOLUTION THROMBUS

- Dissolution
- Réaction inflammatoire
- Fragmentation

# Diagnostic clinique:

**Les signes fonctionnels et cliniques de la TVP sont peu sensibles et peu spécifiques.**

**-il faut rechercher les facteurs de risque**

(interrogatoire minutieux)



# SIGNES CLINIQUES DE LA TVP DES MI

**Unilatéraux++**

**Motif de consultation:**

- **Douleur du MI**

**spontanée ou provoquée par la palpation du mollet 60 % des cas.**

- **Oedème** = tronc collecteur

**ex:un oedème à la racine de la cuisse =TVP iliaque**

- **Chaleur cutanée.**
- **Dilatation veineuse superficielle**

**A l'examen:**

- **Perte de ballottement**
- **Empâtement =signe de Homans**

sensibilité et spécificité < 50 %

**Les TVP les plus fréquentes sont distales**



- **L'examen clinique : bilatéral, comparatif,**
- signes  unilatéraux ++++ surtout à gauche.
- **Inspection :**

. Dilatation veineuse superficielle

. Peau tendue luisante

Œdème : mesure comparative du périmètre



-

# Palpation :

- - Douleur à la palpation le long du trajet veineux à la dorsiflexion du pied : **signe de HOMANS.**
- **Diminution du ballotement du mollet**



- Augmentation de la chaleur locale
- Palpation des pouls +++

**la phlégmatia alba dolens ; +++**





- **B/Phlègmatia cerrulea dolans= phlebite bleue**

- Forme clinique rare

- Associée des signes d'ischémie.




www.vein.co.uk

# SCORE DE WELLS POUR LE DIAGNOSTIC DES TVP PROXIMALES *(LANCET, 1997)*

- Cancer actif ou traitement de moins de 6 mois 1
- Paralysie/parésie/immobilisation récente 1
- Alitement > 3j ou chirurgie majeure <4 semaines 1
- Douleur le long des trajets veineux profonds 1
- Augmentation de volume de tout un membre 1
- Grosse jambe unilatérale (différence > 3 cm circonférence) 1
- Œdème prenant le godet 1
- Réseau superficiel dilaté en l'absence de varices 1
- Diagnostic alternatif (probabilité équivalente ou > à TVP) - 2

- **Score de Wells : résultats**

**Forte probabilité (prévalence de TVP 75 %) > 3**

**Moyenne probabilité (prévalence de TVP 17 %)  2**

**Faible probabilité (prévalence de TVP 3 %) 1 -0**

# EXAMENS COMPLEMENTAIRES

**<u>Biologie</u>**

-PAS TRES SPECIFIQUE

Dosage des D-dimères :

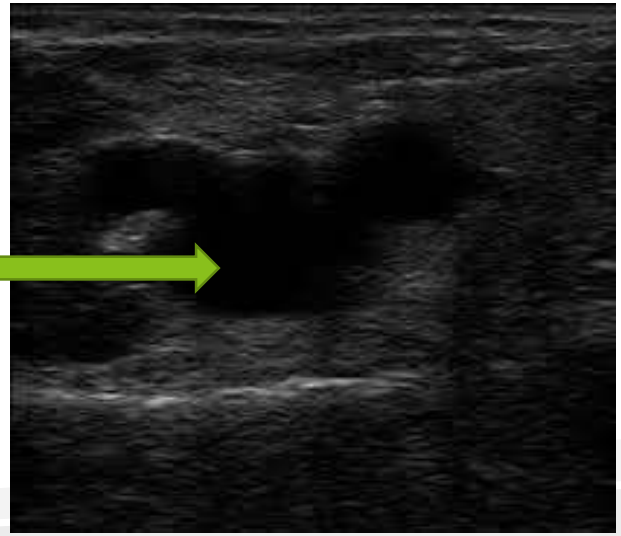
* si négatif (< 500 ng/ml) = pas de thrombose dans 95 % des cas (**valeur prédictive négative**)

- **<u>L'échoDoppler veineux</u>**

examen non invasif qui permet de visualiser

la thrombose en objectivant une dilatation de la veine qui est hyperéchogène et incompressible.

VFC normale

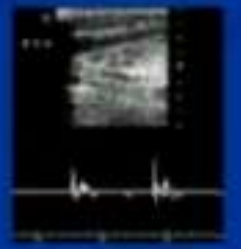


# EXAMENS COMPLEMENTAIRES

## ECHO-DOPPLER VEINEUX



-La référence:
!méthodologie d'examen stricte par un médecin entraîné et sondes adaptées.
!Patient allongé, assis jambes pendantes ou debout



-Informations topographiques et hémodynamiques.

-Diagnostics différentiels
(rupture de kyste poplité, hématome intramusculaire..).



-Sensibilité et spécificité >95 %
pour les TVP symptomatiques.

# EXAMENS COMPLEMENTAIRES

## ECHO-DOPPLER VEINEUX

- **Les types de TVP des MI:**

**-Distales ou surales: (donnant rarement des EP) touchant les veines: tibiales (antérieures, postérieures), péronières, soléaires, gémellaires.**

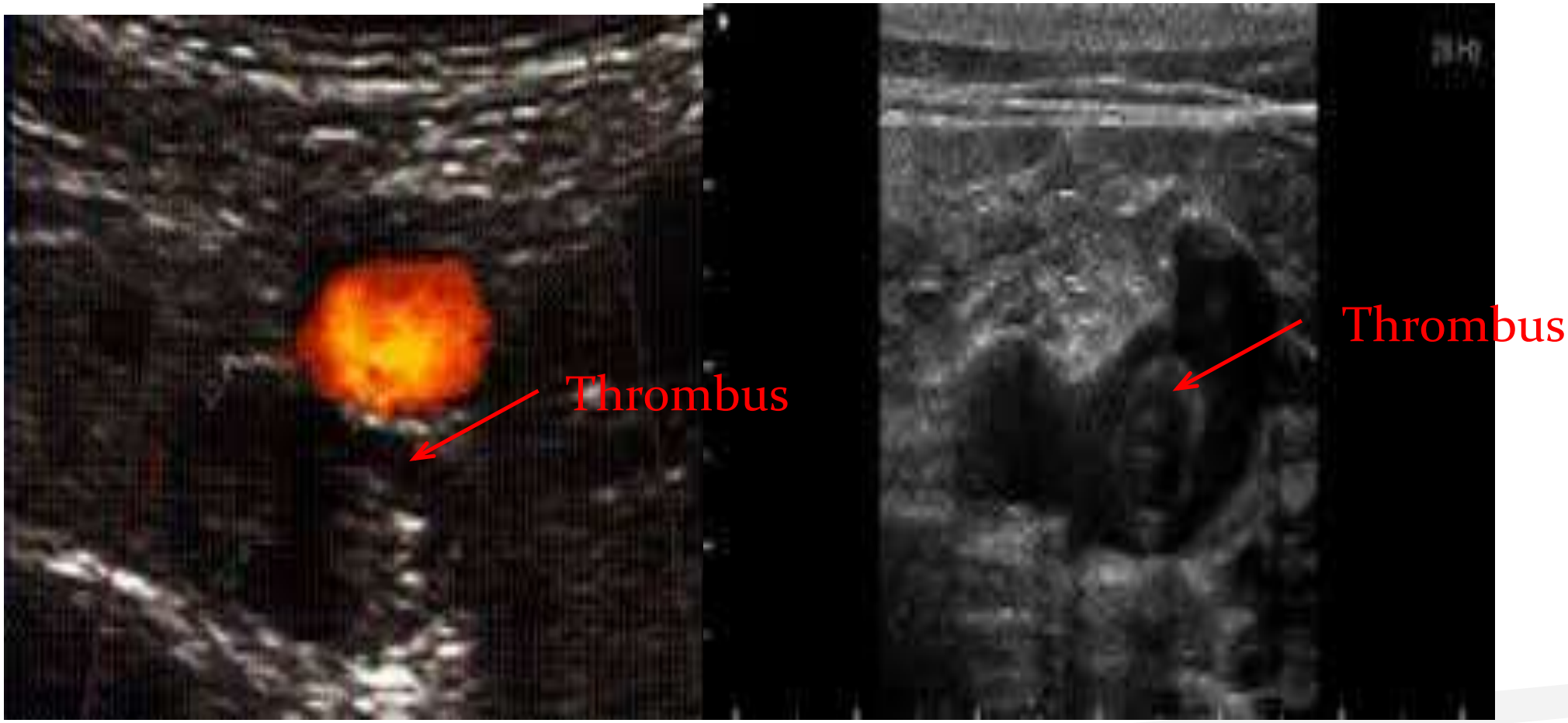
**-Proximales: (pouvant donner une EP) touchant les veines poplités, fémorales (superficielles, profondes ou communes) iliaques (internes ou externes) , VCI.**

- **Contrôles: à j+15, j+45 ,j+3 mois j+6 mois..**

# EXAMENS COMPLEMENTAIRES

## ECHO-DOPPLER VEINEUX

Coupes :
transversales et longitudinales avec compression de
la VCI , des confluents , veines distales ou superficielles.
-Image du thrombus: obstructif , semi-obstructif , flottant ou adhérent, réçent peu échogène ou ancien échogène .
-Veines incompressibles.
-Signal Doppler pulsé: absent, amorti, continu, inversé,reflux, Valsalva.
-Signal Doppler couleur: absent, remplissage partiel,inversion .
-Autres: calibre de la veine, cinétique de la paroi et des valvules


Thrombus
Thrombus

# DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

- **<u>Diagnostic d'une grosse jambe</u>**

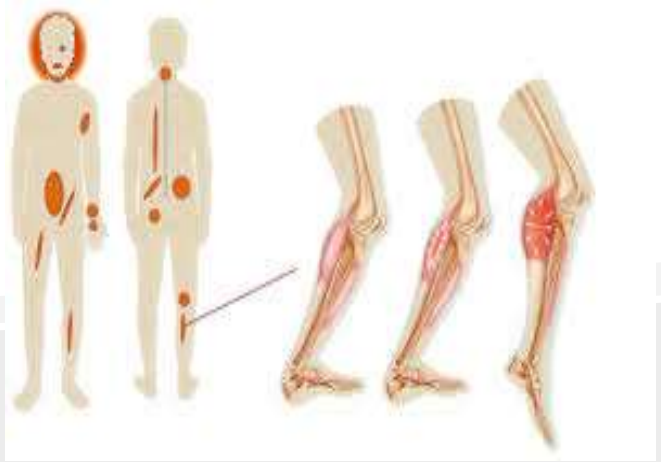
- **Erysipèle** : grand placard rouge,  signes généraux sont sévères origine streptococcique ++++

- **Hématome musculaire** :

Traumatisme, ou de **maladie** hémorragique.

- **Lymphoedème** :œdème élastique de la  face dorsale du







- **<u>Diagnostic d'une douleur du mollet</u>**

- **Claudication intermittente :** il s'agit d'une douleur à l'effort. Il existe une notion de périmètre de marche. Il n'y a pas d'œdèmes. On note l'abolition d'un pouls.

- **Déchirure musculaire** : notion d'effort violent

- **Douleur neurologique** : sciatique en général,

  * Topographie L5 ou S1.

  *Pas de signe local

# DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE

- 1- **Facteurs prédisposants**

  - Age : les sujets âgés font plus de thrombose veineuse que les sujets jeunes

  - Obésité

  - Insuffisance veineuse chronique

  - Alitement, immobilisation, sédentarité

## 2- Etiologies obstétricales

- Plus fréquentes dans le post-partum immédiat (5% dans les statistiques isotopiques)

## 3- Interventions

- Interventions à haut risque :
  * Pelviennes : utérus et prostate
  * Orthopédiques : rachis, hanche, genou, thrombose sous plâtre
  * Carcinologiques
- Interventions à moindre risque :
  * Abdominales
  * Autres (Ophtalmologie, ORL….)

- **4- Etiologies médicales**

- Hémopathies : leucémies, polyglobulie, anémies, thrombocytémies,

- Cardiopathies : insuffisance cardiaque droite ou globale, infarctus du myocarde à la phase aiguë

- Cancers : pancréas, bronches, estomac, prostate, ovaire, sein, thyroïde
- Cirrhose (déficit en ATIII, protéines C et S)

- **- Etiologies iatrogènes**

  - Contraception

  - Cathétérisme veineux

  - Thrombopénie induite par l'héparine, donnant plutôt des thromboses artérielles mais également veineuses

- **6- Anomalies biologiques de l'hémostase**
  - Déficit en antithrombine III (ATIII)
  - Déficit en protéine C (PC)
  - Résistance à la protéine C activée
  - Déficits en protéine S (PS).
  - Anomalies du fibrinogène

- **7- Thromboses veineuses primitives**

Se sont des thromboses veineuses surviennent sans facteur déclenchant et sans anomalie décelable des protéines de la coagulation actuellement connues

# Sémiologie de l’insuffisance veineuse superficielle

# GENERALITES

- Affection relativement bénigne.
- But du traitement :
  - → supprimer les symptômes.
  - → Eviter ou prévenir les complications
  - → Esthétique

# DEFINITION

- Varices des membres inférieurs se définissent comme un reflux de sang dans les veines superficielles entraînant une dilatation permanente et une élongation des veines superficielles dont le trajet devient tortueux, et qui peut s' accompagner d'une altération de la peau ( ulcère, dermite ocre etc.…) en absence d'un traitement efficace.
- Dans la majorité des cas ,aucune cause

→ Varices essentielles

# ANATOMIE DU DRAINAGE VEINEUX

- Il existe deux systèmes de drainage:

  système veineux profond 9 / 10.

  système veineux superficiel 1 / 10.

Dont le drainage du réseau superficiel se fait par:

- veine saphène interne.
- veine saphène externe.
- perforantes.

# Physiologie du drainage veineux :

- Comment le sang veineux remonte t-il ?

« fonctionnement normal » les mécanismes permettant le retour veineux

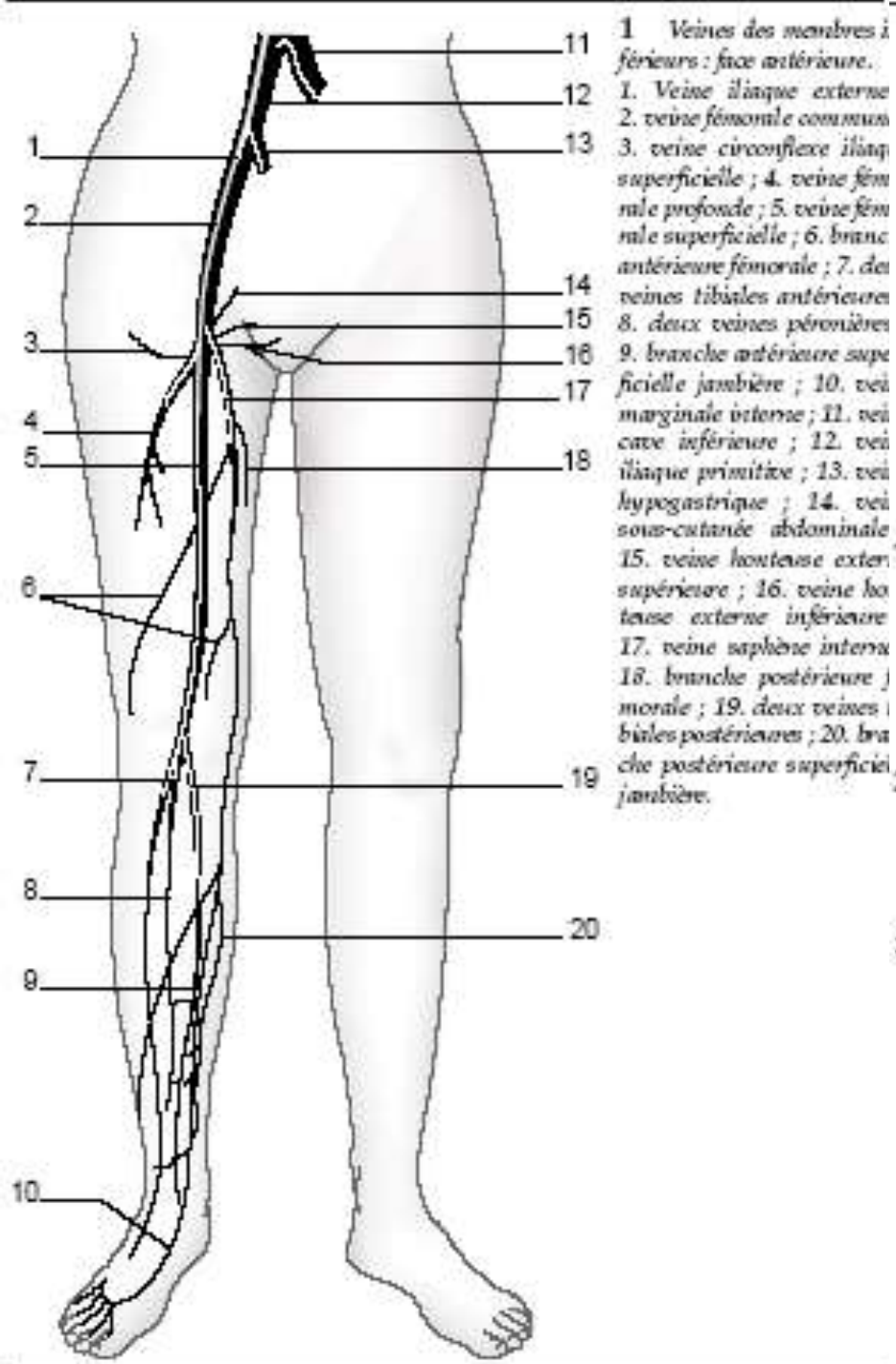
- aspiration cardiaque (diastole).

- respiration abdominale et le rôle du diaphragme.

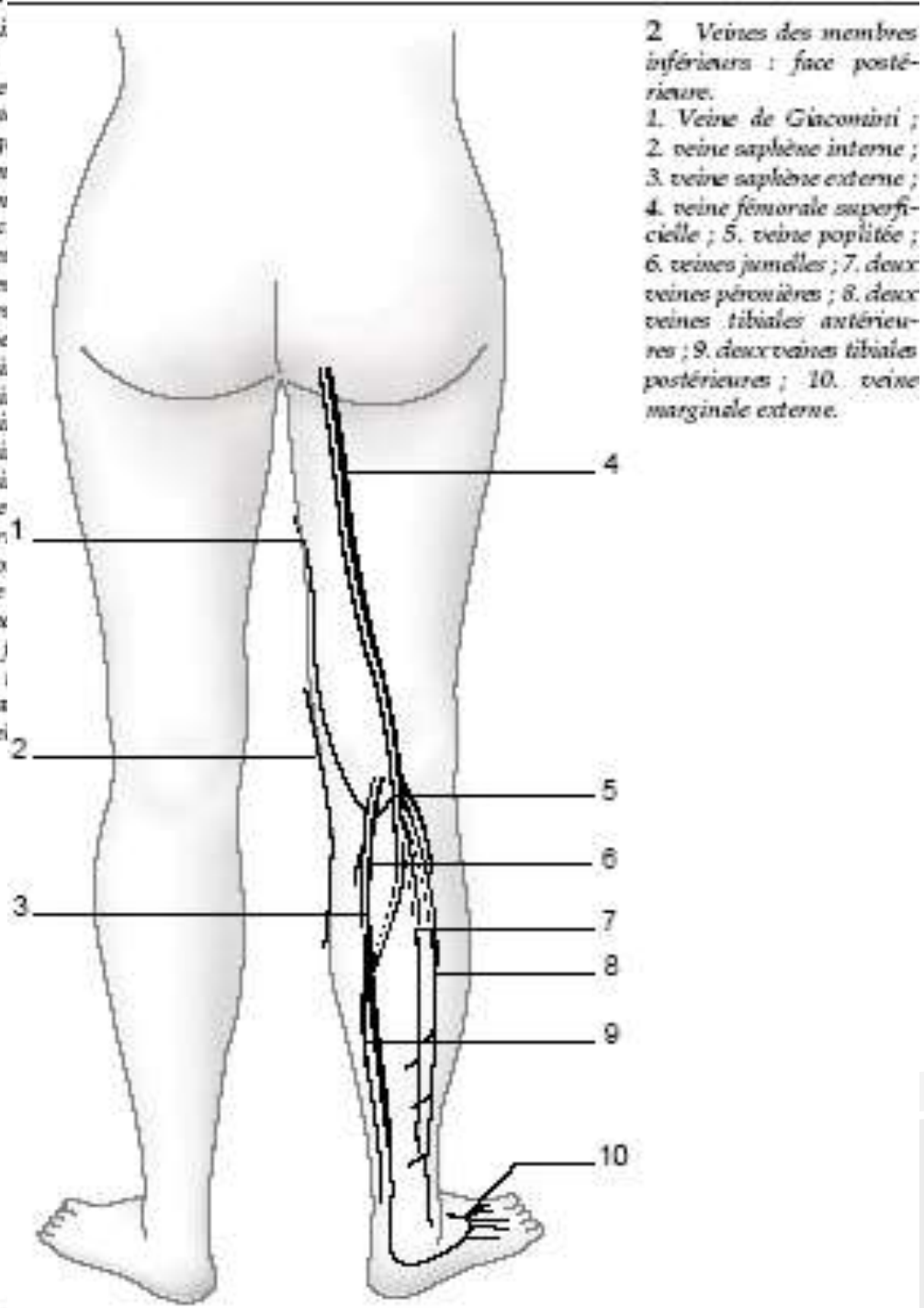
- le tonus et contractilités des veines.

- écrasement de la semelle veineuse et la voûte plantaire.

- la pompe musculaire du mollet.




**1** *Veines des membres i*
*férieurs : face antérieure.*
*1. Veine iliaque externe*
*2. veine fémorale commun*
*3. veine circonflexe iliaq*
*superficielle ; 4. veine fém*
*rale profonde ; 5. veine fém*
*rale superficielle ; 6. branc*
*antérieure fémorale ; 7. de*
*veines tibiales antérieure*
*8. deux veines péronières*
*9. branche antérieure supe*
*ficielle jambière ; 10. vei*
*marginale interne ; 11. vei*
*cave inférieure ; 12. vei*
*iliaque primitive ; 13. vei*
*hypogastrique ; 14. vei*
*sous-cutanée abdominale*
*15. veine honteuse exter*
*supérieure ; 16. veine ho*
*teuse externe inférieure*
*17. veine saphène interne*
*18. branche postérieure*
*morale ; 19. deux veines*
*bitales postérieures ; 20. bra*
*che postérieure superficie*
*jambière.*




**2** *Veines des membres inférieurs : face postérieure.*
*1. Veine de Giacomini ;*
*2. veine saphène interne ;*
*3. veine saphène externe ;*
*4. veine fémorale superficielle ; 5. veine poplitée ;*
*6. veines jumelles ; 7. deux veines péronières ; 8. deux veines tibiales antérieures ; 9. deux veines tibiales postérieures ; 10. veine marginale externe.*

# NOTIONS ETIOLOGIQUES

- Varices essentielles.

- Varices secondaires n’apparaissent qu’au cours de la vie.

# LES FACTEURS PREDISPOSANTS

- Les facteurs déclenchants : sont nombreux.

  - troubles endocriniens chez la femme (puberté, grossesse, ménopause, contraception orale,etc..)
  - obésité.
  - compression : fibrome utérin.
  - position debout prolongée.
  - sédentarité exagérée.
  - la chaleur (soleil, sauna).
  - pied plat.
  - les talons trop haut.

# MOTIF DE CONSULTATION

- Problème esthétique (++++) : il s'agit de varicosités ou de paquets variqueux tortueux, inesthétique.

- Lourdeur de jambe, majorée par orthostatisme.

- Complications médicales :
  - prurit ou démangeaisons.
  - dermite ocre.
  - phlébite superficielle ( douleur et rougeur).
  - ulcère variqueux.

# SYMPTOMATOLOGIE

- La maladie variqueuse évolue en 4 stades

  stade I : pas de varice visible, mais présence de signes fonctionnels : lourdeur des jambes, crampes nocturnes, paresthésies (fourmillement), douleur le long du trajet veineux, prurit, œdème de la cheville le soir.

  stade II : varices visibles.

  stade III : troubles trophiques, hypodermite : dermite ocre.

  stade IV : ulcère variqueux, plaie provoquée par un traumatisme aucune tendance naturelle à la cicatrisation.

## SYMPTOMATOLOGIE

- Complications :
    - hémorragie.
    - phlébite superficielle.

# EXAMEN CLINIQUE

## INSPECTION

- Malade en position debout et couché.
  - dilatation variqueuse tortueuse, inesthétique.
  - trajet par rapport aux 2 saphènes.
  - lésions cutanées ( dermite ocre ou ulcère).
  - phlébite superficielle.

# Examen sus pubien







# Varice saphène interne






Varice saphène interne

# Paquet variqueux du mollet



# Ulcère variqueux



# Ulcère variqueux



# EXAMEN CLINIQUE

## PALPATION

- Examen des pouls périphériques.
- **Manœuvre de Schwartz :**
- **Manœuvre de Trendelenburg :** pose d'un garrot au-dessus des paquets variqueux la jambe surélevée, et remplissage des varices lors du passage en position déclive)

  - manœuvre positive : incontinence de la saphène interne

  - manœuvre doublement positive : la saphène et les perforantes sont incontinentes.

# Palpation et percussion:

- Palper de proche en proche le trajet des GVS et PVS.
- La pulsion à la toux principalement au niveau de la jonction de la GVS avec la fémorale commune permet de percevoir un thrill témoin d'une insuffisance valvulaire ostiale.
- Le signe du flot consiste à émettre quelques chiquenaudes avec le doigt sur la GVS et sur la PVS et à percevoir en aval une ondulation due au flux sanguin. Ceci permet de suivre une veine de proche en proche et de rattacher certaines collatérales à un tronc saphénien.

- **La manœuvre de Schwartz** consiste à émettre quelques chiquenaudes au niveau de la veine en aval et à percevoir un ébranlement de la colonne sanguine en amont. Ce signe témoigne d'une insuffisance valvulaire étagée.
- **L'épreuve de Trendelenburg** Elle permet de rechercher une insuffisance valvulaire ostiale de la GVS et consistait à mettre le malade en décubitus en surélevant le membre inférieur pour vider le sang des veines superficielles puis de placer un garrot élastique à la racine de la cuisse. Le patient était alors mis en position debout et le garrot était levé. Le remplissage progressif du réseau variqueux de haut en bas témoignait de l'incontinence ostiale.

- **Les manœuvres de Pratt et de Perthes** ne figurent que dans les anciens ouvrages phlébologiques. Elles permettaient d'apprécier la perméabilité des troubles profonds et de localiser les différentes perforantes incontinentes. Elles ne sont plus d'actualité aujourd'hui, l'exploration à l'échodoppler étant beaucoup plus précise.

# Manœuvre ce Schwartz





# Manœuvre de Trendelenburg







# Manœuvre de Perthes



# EXAMEN CLINIQUE

## AUSCULTATION

- Auscultation des paquets variqueux à la recherche d’un souffle.

# EXPLORATION

- BUT :

  - perméabilité et continence du réseau profond.

  - mécanisme de l'insuffisance veineuse superficielle.

  - topographie et quantification des reflux.

# EXPLORATION

- **Phlébographie** soit ascendante ou descendante.

à la recherche d'une insuffisance valvulaire (perforantes).

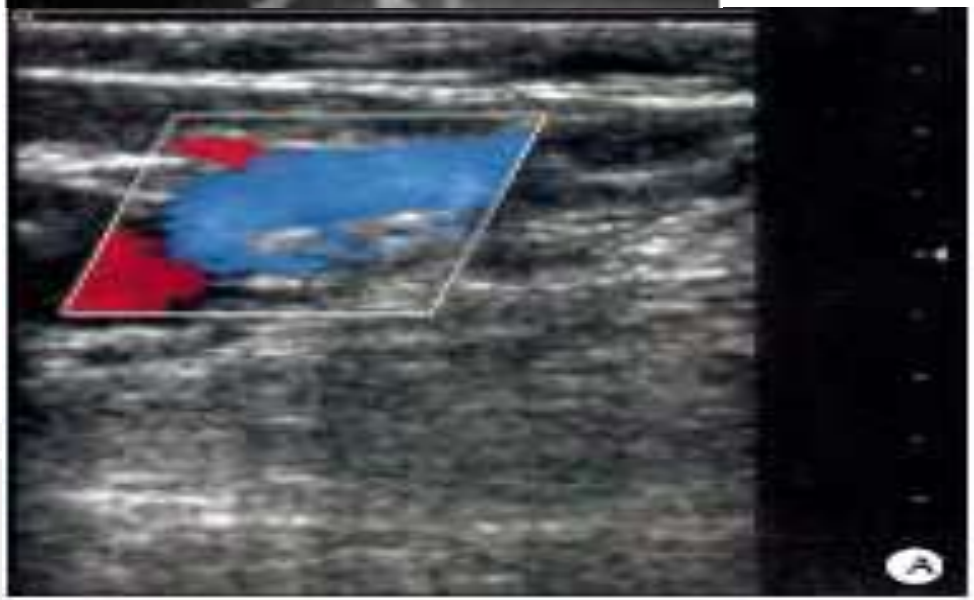
- Exploration ultrasonique :

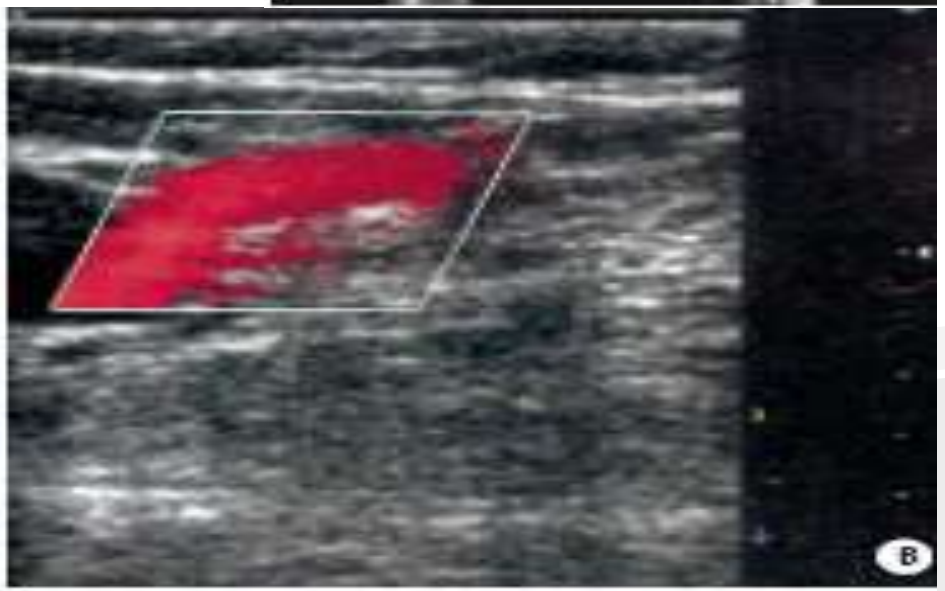
- doppler continu : renseigne sur la perméabilité de la veine, l'existence de reflux (certaines manœuvres dynamiques permettent la recherche du reflux).

- échotomographie doppler : étude morphologique et hémodynamique dans le meme temps.






A


B

# Complications:

1. Hémorragies sous-cutanées, pétéchies, rarement extériorisée (traumatisme)
2. Thrombose variqueuse
3. Œdème chronique
4. Surinfection
5. Ulcère variqueux
6. Pigmentation cutanée ocre,Dermite ocre, atrophie cutanée
7. Eczéma de contact
8. Ulcère variqueux
9. Ulcère de la jambe